

אסדרת מערך התמריצים במכרז הסיעוד

שלב שלישי – העמקה בפתרונות נבחרים

אנו מודים לכם על בחירתכם במחלקת Government & Public sector ב-EY לספק את השירותים המקצועיים שלנו במסגרת מכרז 'מדיניות רגולציה וצמצום בירוקרטיה' לפרויקט 'אסדרת מערך התמריצים בתחום הסיעוד' בהתאם לתכנית עבודה שאושרה על ידכם מיום 06.02.22. ביצענו את עבודתנו עבור הלקוח- אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה בלבד ולא עבור צד שלישי אחר כלשהו. תוצרי העבודה מתייחסים לנושאים שהוגדרו במסגרת תכנית העבודה והם מבוססים על מידע שהושג ע"י EY באמצעות תהליכי העבודה שסוכמו עם הלקוח וסופקו על ידו בין החודשים 12.22-02.22. תוצר העבודה אושר ע"י הלקוח במהלך העבודה המשותפת ול-EY לא תהיה כל אחריות לגבי שימושים עתידיים, לאחר מועד מסירת המסמך הסופי ללקוח – 12.22. במסגרת עבודתנו, התבססנו על חומרים, נתונים ומידע שהתקבל מכם ולא יכולנו לתת מענה לטעויות שיכלו לבוע מרישום, עיבוד או דיווח של הנתונים באופן בלתי מדויק ולכן לא נהיה אחראיים לפגם אשר יכול לבוע מעיבוד הנתונים או המידע הקשור אליהם. שירותנו הינם שירותי ייעוץ מטבעם ולפיכך השירותים לא כללו בדיקה לגילוי הונאה או מעשים בלתי חוקיים וכן לא יהוו ביקורת, סקירה או בחינה של דוחות כספיים לפי כללי ביקורת מקובלים והדוחות שלנו לא יהוו חוות דעת או ייעוץ משפטי. אנו לא נוטלים על עצמנו אחריות כלפי מוצרים, תכניות או שירותים כלשהם של צד שלישי כלשהו ולא נהיה אחראיים להתאמתם להוראות אחרות שלכם.

לשאלות ו/או הבהרות בכל שלב ניתן ליצור קשר עם חגית צור, שותפה ומנהלת מחלקת מגזר ציבורי - Government & Public sector
Hagit.Zur@il.ey.com, משרד: 073-3799925, טלפון: 054-4736510

תוכן עניינים

- 01 רקע וסיכום שלב ב
- 02 מתודולוגיה – אופן הניתוח
- 03 תמריץ כלכלי לחברות הסיעוד מבוסס מדידת תוצאות
- 04 מדידת חברות הסיעוד על איכות הטיפול (תפוקות)
- 05 פתרונות שנבחנו אך לא נבחרו להעמקה
- 06 צעדים להמשך

מטרת הדיון

הצגת ניתוח עומק לשני פתרונות וקיום דיון משותף על מערכת תמריצים
אפשרית עתידית במערך הסיעוד

01. רקע וסיכום שלב ב

רקע לפרויקט



החלטת הממשלה לוותה בהקמת וועדה בין-משרדית. מטרות הוועדה היו:



הגדרת תפקידים

גיבוש הגדרות תפקידים מחודשות למטפלים, כולל מסלולי הכשרה וקידום



הכשרה

גיבוש תפיסת הכשרה וקביעת סטנדרט רצוי להתמקצעות



מודל יישום והטמעה

גיבוש מודל לתוכנית יישום והטמעה, כולל הצבת יעדים

המטפלים הישראלים בזקנים

טיוטת המלצות הוועדה הבין-משרדית, אוגוסט 2021

החלטת הממשלה 43 - "מפת דרכים לענף המטפלים הישראלים בקשישים הסיעודיים" **באה לקדם שינויים מהותיים בענף המטפלים בזקנים**, לאור פערים גדלים והולכים בין איכות הטיפול והיצע המטפלים לבין צרכיהם המורכבים והגוברים של הזקנים.

במסגרת החלטת הממשלה התקבלו החלטות ליישום אשר מטרותיהן העיקריות הן:

1. מעבר לטיפול מותאם להזדקנות מיטבית, **למניעת הידרדרות ולשיקום**
2. שיפור **איכות הטיפול** שהמטפלים מעניקים לזקנים סיעודיים
3. הגדלת **היצע המטפלים**
4. הגדלת **הפריון של המטפלים**

טיוטת המלצות הוועדה*



הקמת מערך תמיכה למטפלים

מערך תמיכה למטפלים במתכונת קבוצות תמיכה, כאשר ההשתתפות בקבוצת התמיכה תתוגמל בשכר



תמריצי שכר למטפלים

השתתפות בהכשרות תיחשב כעבודה ותתוגמל בשכר, תיתכן עלייה בשכר ע"פ דרגת המטפל



פיתוח הכשרות, וקביעת סטנדרטים לגופי הכשרה

פיתוח קורסים להכשרה תואמת דרגה



הגדרה חדשה לתפקיד המטפל ודרגות קידום

אופק תעסוקתי, הרחבת תחומי אחריות, והכרה במטפל כשותף במערך המקצועי



גיבוש תמריצים לשינוי המערכת לדוחקת תלות

שינוי במבנה התמריצים במטרה לעודד טיפול דוחק תלות והתמקצעות של כוח האדם



פיתוח מענים מותאמים לבני משפחה מטפלים

הנגשת מידע לבני המשפחה והפנייה שלהם לשירותים המיועדים עבורם



הקמת מערך פיקוח ובקרה

חיוב נותני השירות להליך מדידה פנימי יחד עם הקמת מערך מדידה ובקרה חיצוני



פיתוח מנגנונים לשיתוף מידע

שילוב מידע מבטל"א למטפל לאחר קביעת הזכאות, וקיום הערכת מצב המטופל פעם בשנה לטיוב הטיפול

רקע לפרויקט

המדריך לרכש חברתי – ספטמבר 2016

המדריך כולל את המלצות הצוות הממשלתי לטיוב האספקה של שירותים חברתיים במיקור חוץ, שגובשו בתהליך שיתוף בין – מגזרי במסגרת השולחן העגול במשרד ראש הממשלה.

המדריך מבטא, בהתאם להחלטת הממשלה, אמות מידה לשירות חברתי ואיכותו, הגדרת תהליך העבודה, הגברת התחרות טרם תקופת ההתקשרות ובמהלכה והלימה בין תוכן ההתקשרות לבין תוכן הבקרה והפיקוח.

☆☆☆ הגדרת סטנדרטים ומדדים באופן שיביא לשירות מצוין

- סטנדרטים להבטחת בטיחותו וכבודו של מקבל השירות – בטחון קיומי
- סטנדרטים להצלחת השירות – תיאוריית השינוי
- מדדי תוצאה, תפוקה, תשומה

הגדרת היישום למדדים

- שיח עם מפעילי השירות
- תגמול וקנס
- תשלום
- בחירת מפעילי שירותים



המודל הלוגי

של המדריך לרכש חברתי

המדריך לרכש חברתי מעודד בחינה של השרות באמצעות תיאוריית השינוי. תיאוריית השינוי עצמה מתארת את השינוי הרצוי, שצפוי להתרחש עקב התערבות ופעולות מסוימות. במסגרת העבודה בחנו את מערכי התמריצים הנוכחיים במכרז הסיעוד בין היתר על פי המודל הלוגי שמציב המדריך.

המודל הלוגי מציע חלוקה ברורה של השינוי אשר ברצוננו לעשות לתשומות, תפוקות ותוצאות. ליבת המודל עוסקת בשלושת המרכיבים (תשומות, תפוקות, תוצאות), בקשרים וכיצד הם משפיעים האחד על השני, כל זאת בראיית השינוי הרצוי.



מטרת הפרויקט

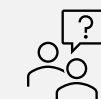
רקע



לגמלת הסיעוד של הביטוח הלאומי זכאי תושב ישראלי מעל גיל הפרישה שנמצא כי הוא זקוק לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום, שסכום הכנסותיו לא עובר את הקבוע בחוק ושאינו מקבל גמלה סיעודית אחרת מגוף ממשלתי. במסגרת הזכאות, זכאי הקשיש לגמלה כספית, שעות טיפול בביתו המסופקות על ידי חברת סיעוד ו/או שירותים נוספים.



צורך



כיום, אין מדיניות ממשלתית המקבלת ביטוי אופרטיבי ששמה במרכז את הזקן ומטרתה לדחוק עד כמה שאפשר את תלותו בזולת. זאת ועוד, בקרב הגופים האחראים על הטיפול הסיעודי בקהילה, לא קיים אף גוף אשר תמריצו הכלכלי לשמר את רמת התפקוד של הקשיש.

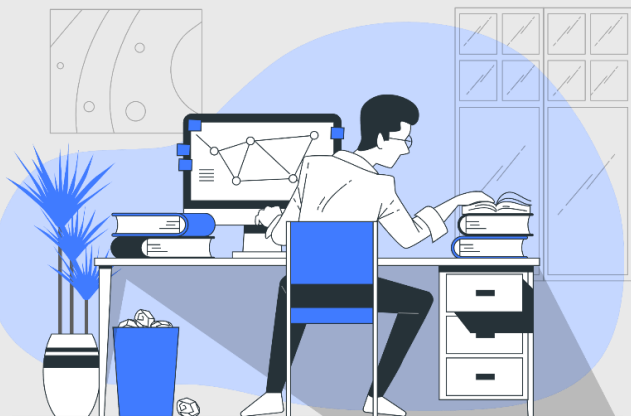


מטרה



מטרת הפרויקט היא לבחון את המידה שבה מבנה התמריצים הקיים במכרז הסיעוד בקהילה מקדם תכליות של מניעת הידרדרות, שיקום והזדקנות בריאה וגיבוש חלופות למערך תמריצים עתידי אשר יקדם תכליות אלו

שלבי העבודה בפרויקט



ניתוח מעמיק לחלופות נבחרות
בחינת השלכות, עלויות ואפקטיביות של
מספר חלופות נבחרות וכן מיפוי החסמים
ליישום החלופות

תוצרי השלב:

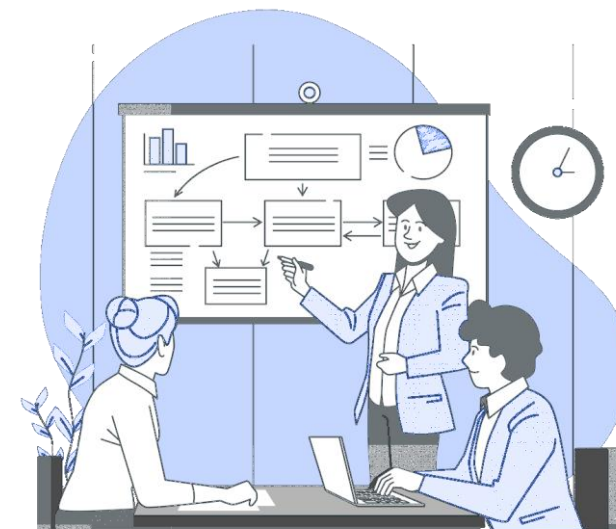
- ניתוח עומק של השלכות יישום חלופות



גיבוש חלופות תמריצים
גיבוש חלופות עבור מבנה התמריצים
העתידי, ניתוח היתרונות והחסרונות של כל
חלופה ואופן שילובה במכרז החדש

תוצרי השלב:

- מסמך חלופות עבור מבנה התמריצים
- ניתוח יתרונות וחסרונות עבור החלופות



מיפוי מצב קיים וסקירה משווה
ניתוח מבנה התמריצים הקיים כיום וסקירת
מבני תמריצים מובילים בתחום מישראל
והעולם

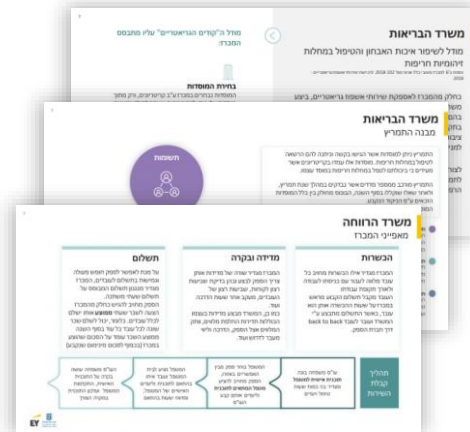
תוצרי השלב:

- מיפוי מצב התמריצים הקיים
- סקירה בינלאומית ובישראל
- סקירת ספרות רלוונטית
- סיכום תובנות עיקריות שעלו בתהליך

תוצרים מרכזיים משלב מיפוי המצב הקיים

מיפוי וניתוח בעלי עניין מרכזיים

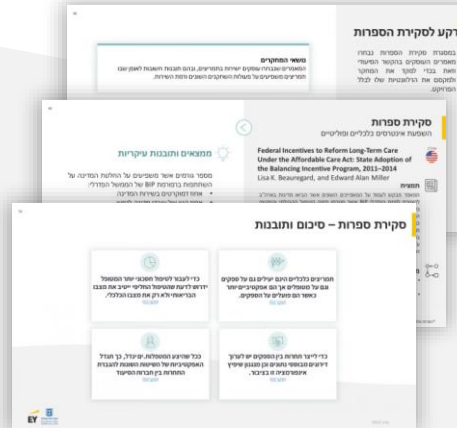
מקרי בוחן מישראל



סקירה בינלאומית

סקירת ספרות

גיבוש תובנות מרכזיות



במסגרת השלב השני אופיינו מספר גדול של פתרונות ותמריצים למעוך הסיעוד ע"י צוות הפרויקט מטעם EY.

השלב בנוכחות צוות התמריצים המורחב.

בשיבה הוצגו 41 פתרונות שונים אשר עשויים לשפר היבטים שונים במערך הסיעוד.

במהלך הישיבה דירגו המשתתפים את הפתרונות השונים ובחרו את 6 הפתרונות אשר לגביהם תתבצע העמקה וניתוח בשלב השלישי של הפרויקט.

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ
מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון	מחלקת תכנון																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

הפתרונות שנבחרו להעמקה ע"י צוות הפרויקט המורחב

על פי הדירוג אשר התבצע בישיבה ב-27.06

פרסום לציבור של מדדים של
חברות הסיעוד

תמריץ כלכלי לחברות הסיעוד
באמצעות מדידת תוצאות

תמריץ כלכלי למטפלות
באמצעות מדידת תפוקות

תעריף שונה במכרז לחברות
הסיעוד בהתאם לסלי איכות
שונים

חיזוק המקצועיות ויצירת אופק
קידום למטפלות

מדידת חברות הסיעוד על
טיפול דוחק תלות (איכות
הטיפול)

פתרונות שנבחרו במסגרת מצגת זו

פתרונות להעמקה עתידית

02. מתודולוגיה – אופן הניתוח

שיטת העבודה בשלב השלישי



העמקנו וניתחנו

ריכזנו את כל התובנות, הבעיות והפתרונות שעלו לאורך התהליך לכדי תוצר מסכם אשר יאפשר **שיח משותף ומיפוי מערך עתידי** המתמרץ את כלל השחקנים באופן מיטבי דחיקת התלות של המטופלים



נפגשנו

ביצענו **פגישות ושוחחנו עם צוות הפרויקט** המצומצם לחשיבה ועיבוד התוצרים שעלו במהלך העבודה. קיבלנו תגובות ותובנות חשובות שסייעו בהמשך התהליך



מיפוי בעיות ופתרונות

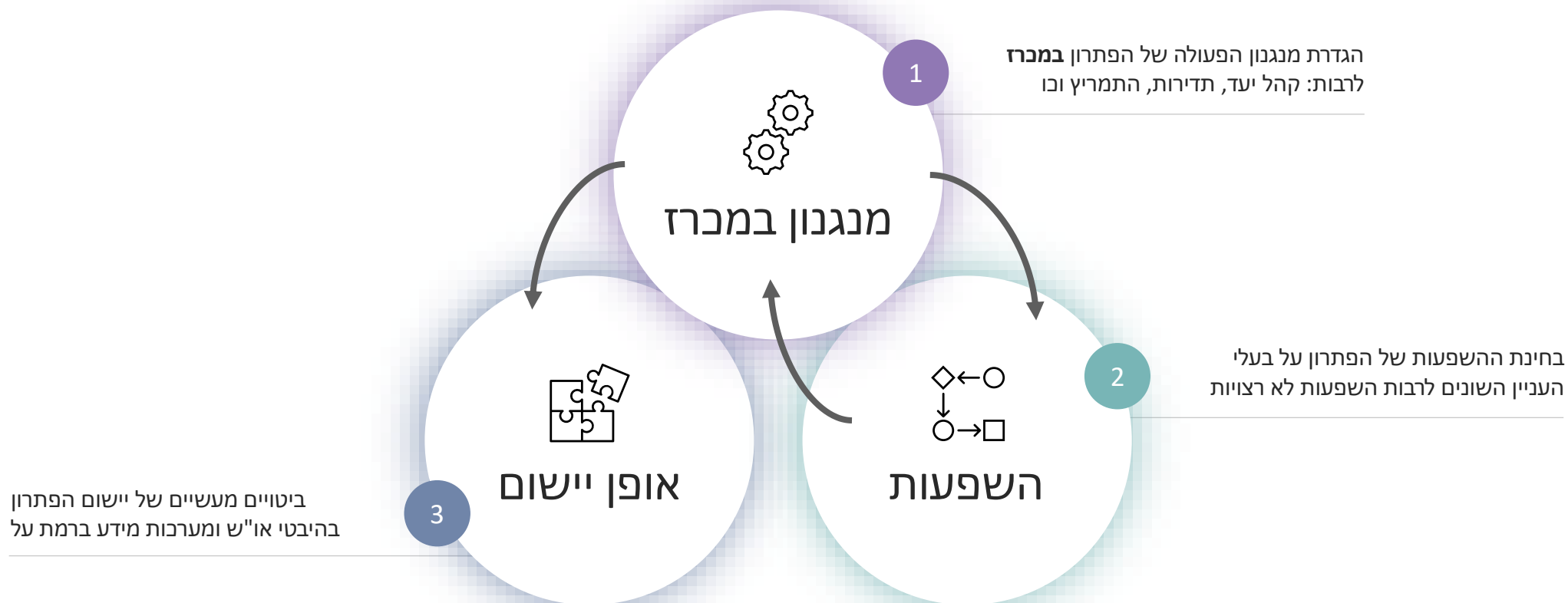
מיפינו את הבעיות שעלו בשלב א' וביצענו תהליך משלים של **Top Down לזיהוי אפשרויות לפתרון של בעיות** אלו. מרבית הפתרונות מתבססים על עקרונות שעלו בשלב הראשון ועל החומרים שנסקרו



סיעור מוחות

ביצענו סיעור מוחות בתהליך **Co-Creation** עם מומחי התוכן בצוות הפרויקט הפנימי לטובת **הצפת רעיונות ראשוניים** מבוססי תובנות שעלו בפרקים השונים של מיפוי המצב הקיים והסקירה המשווה

אופן הניתוח



03. תמריץ כלכלי לחברות הסיעוד באמצעות מדידת תוצאות

ניתוח מעמיק לחלופת הפתרון

מנגנון המודל

מבט על

אופן תמרוץ

בנוס שנת (יחסי לכמות שעות הטיפול שסופקו ע"י החברה) לחברות הנמצאות בראש הדירוג ע"ב ביצועי השנה החולפת

תדירות

מדידה חד שנתי ראשית + התבססות על הדוחות והמידע המועבר לביטוח הלאומי כחלק מתנאי המרכז (למעט בשנה הראשונה בה כל מטופל יבדק פעמיים)

קהל יעד

התמריץ מיועד לחברות הסיעוד

- במסגרת חלופת הפתרון, מוצע למדוד את תוצאות חברות הסיעוד ולתמרץ אותן בהתאם. אחת לשנה כל מטופל יעבור בדיקה ע"י גורם מקצועי טיפולי מוסמך אשר תכלול מדדים על פי החלטת הביטוח הלאומי והגורמים המקצועיים (פירוט של מספר חלופות מדידה בשקפים הבאים).
- נתוני המדידה של כל חברה נבדקים אל מול ביצועיה העצמיים בשנים שעברו וכן אלו מול מדד יחס של כלל החברות הפועלות בקטגוריה של אותה החברה. הנתון הגבוה מבין השניים (שיפור עצמי או מול המתחרים) הינו הממד השנתי לביצועי החברה.
- החברות מחולקות לקטגוריות ע"פ גודל החברה (כמות מטופלים/שעות טיפול). יתכן והחברות יחולקו אף לפי אזורי פעילות במידה והנתונים אשר יעלו לאורך הדרך יתמכו בצורך לחלוקה זו.
- אחוז מסוים מהחברות אשר נמצאות בראש הרשימה של כל קטגוריה, בהתאם לציון בממד יקבלו **בנוס שנת שיקבע** בהתאם למיקומן בדירוג וכן באופן יחסי לכמות שעות הטיפול שהן מעניקות למטופלים (מודל דומה בארה"ב קבע תוספת של עד 5%). היות ולשיפור השירות יש עלות שולית פוחתת (כלומר – כל השקעה במטופל נוסף תעלה לחברה פחות מאשר המטופל הקודם) חישוב התמריץ יתבצע כך שעל כל שעת טיפול יקבלו החברות בנוס קטן יותר מאשר השנה שלפניה.

פירוט
התהליך
ברמת על**

כל מטופל נמדד אחת לשנה ע"י גורם מקצועי (ניתן לקבוע מדידה מדגמית של אחוז מטופלים מסוים מכל רמה)

בסוף השנה, סך המדידה משוקללת לממד אחיד אשר מייצג את ביצועי החברה באותה השנה

החברות נמדדות אחת מול השנייה וכן אל מול ביצועיהן בשנים הקודמות

החברות מדורגות ע"פ המדידה והחברות המדורגות בראש הרשימה זוכות לבנוס בשנה העוקבת

הבנוס מחושב כך שהחברה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר תקבל את הבנוס הגבוה ביותר אשר ילך וירד עד לחברה האחרונה הזכאית

לאורך המצגת סימון זה מסמל כי ישנם תימוכין ממקרים אחרים בעולם לפרט זה של הפתרון אשר יפורטו בחלק המיועד לכך בהמשך המצגת

* פירוט המנגנון האמריקאי Home Health Value-Based Purchasing (HHVBP) מופיע בשקפים אודות תימוכין מהעולם

** התהליך לעיל מפרט את השלבים הקבועים לאחר שכבר נקבעו ואופיינו מדי היחוס בשנת הבסיס

מנגנון המודל

פירוט התהליך

התהליך המפורט להלן הינו הסבר כללי על המבנה. ניתן לקבוע כי שנת התשלום הראשונה למודל תידחה לשנת התשלום השנייה כך שהספקים יוכלו להתרגל למדידה ולהבין את התוצאות וכיצד הם יכולים לשפר אותן

שנת הבסיס נועדה לייצר בנצ'מארק ומצע ברור להשוואת ביצועים לשנים הבאות. בשנת הבסיס נמדדת כל חברה על ביצועיה אך למדידה זו אין עדיין השלכות כלכליות על החברה באופן ישיר

בשנת הביצוע נמדדות החברות על ביצועיהן באופן זהה לשנת הבסיס, אך הציונים אשר ניתנים הינן ביחס לשני מדדי יחוס שונים:

1. מדד שיפור עצמי: השיפור בביצועי החברה ביחס לביצועיה בשנת הבסיס
2. מדד ביצועים כללי: ביצועי החברה לעומת מדד היחוס הקטגורי של כלל החברות משנת הביצוע

מדידה כפולה זו מאפשרת תימרוץ של החברות הטובות ביותר מצד אחד, ומצד שני עידוד חברות לשיפור מתמיד (תמריץ גם לחברות הנמצאות בתחתית הרשימה בשנה נתונה)

בשנת התשלום מבוצע תשלום הבונוס לחברות בהתאם לביצועים של שנת הביצוע, וזאת לאור הדירוג הראשי שלהם. הדירוג הינו הציון המשוכלל הגבוה מבין שני המדדים שנבדקו בשנת הביצוע. בהתאם לדירוג החברה על ביצועיה ישנה נוסחה אשר מחשבת את הבונוס אשר תקבל החברה.

על מנת למנוע מצב בו חברה יורדת דירוג בשנה נתונה על מנת לשפר בשנה הבאה, יינתן דירוג מופחת לחברה אשר הראתה ירידה משמעותית בביצועים ועליה בשנה שלאחר מכן

מדידה של המטופלים

שקלול תוצאות המדידה של שנת התשלום כך שהיא הופכת לשנת הביצוע של השנה שלאחר מכן

חישוב הבונוס לחברות אשר דורגו בראש המדד והעברתו לחברות

ביצוע מדידה חוזרת של המטופלים אשר נבדקו בשנת הבסיס לאורך שנת הביצוע

שיקלול תוצאות המדידה לכדי ציון אחיד לכל חברה ודירוג החברות ע"פ הציון שקיבלו

בסוף שנת הבסיס מתבצעת מדידה נוספת של המטופלים. המדידה משוקללת לכדי מדד בנצ'מרק על רמת החברה והשוק בכלל

ביצוע מדידה מדגמית של מטופלים (לחלופין מדידה של כלל המטופלים) באמצעות גורמי מקצוע מוסמכים

חלוקת חברות הסיעוד לקטגוריות מבוססות גודל (ואולי אזור גיאוגרפי)

הגורם הממשלתי

שנת התשלום ---<

קבלת בונוס שנתי על השנה החולפת בהתאם למיקום הספק בדירוג הכללי

קבלת מידע אודות מיקום הספק ביחס לחברות האחרות

העברת דיווחים שוטפים על פעילות החברה ומצב המטופלים

קבלת מידע אודות מיקום הספק ביחס לחברות האחרות כך שיוכל להשתפר לקראת השנה הבאה

העברת דיווחים שוטפים על פעילות החברה ומצב המטופלים

שנת הבסיס ---<

ספקי שירותי סיעוד

מקרא:

מדידה

פעולה

מנגנון המודל

חלופות לשיטות מדידת תוצאות



1. המנגנון האמריקאי

המנגנון האמריקאי מתמרץ על פי מערכת דיווח OASIS אשר מבוססת על שאלונים למטופלים הממולאים ע"י בודק מוסמך מטעם חברת הסיעוד (אחות וכדומה), מערכת של שאלוני שביעות רצון וכן מספר מדדי דיווח עצמי של החברות על נתוני החברה עצמה (ניקוד על עצם הדיווח)

2. InterRAI*

בניית מדד ממספר סעיפים של סקר ה Resident Assessment Instrument-Home Care (RAI-HC) אשר מהווה תקן איכות בינלאומי למדידת שירות טיפול ביתי (התקן נמצא בשימוש במספר מדינות כגון: בלגיה, פינלנד, גרמניה, איטליה, הולנד, אירלנד, חלק ממדינות ארה"ב, אוסטרליה ועוד). דוגמה למדדים אפשריים ניתן למצוא במאמר של Aylin Wagner, René Schaffert, Nathalie Möckli, Franziska Zúñiga, Julia Dratva**

3. יצירת מדד חדש המותאם לנתונים הקיימים בישראל

בניית מדד אשר מבוסס על נתונים שיבחרו ע"י גורמי המקצוע בישראל. מדידה זו תהיה מבוסס על מבנה השירות והגמלה כפי שהוא בנוי כיום. במידה ואפשרות זו מיושמת נכון לבחון אפשרות לשילוב של שתי שיטות יחדיו (לדוגמה: הדרדרות ברמה + אשפוז)

שימוש בתקני מדידה בין-לאומיים

תהליכי המדידה, באם יהיו בתקן וסטנדרט בינלאומי יאפשרו השוואה של השירות אותן מקבלים מטופלים בארץ אל מול מדינות אחרות ברחבי העולם (בין אם משתמשים בתקן של ארה"ב או של interRAI). השוואה בינלאומית כזו תאפשר לגלות היכן נקודות החוזק והחולשה בטיפול בארץ אל מול מדינות מקבילות שמשתמשות באותו מדד ובכך גם לבחון לאורך זמן את הצלחת התמריץ. מאידך, שימוש בתקן מדידה חד שיצריך שינוי מהותי בהליך המדידה המבוצע בארץ דבר אשר יגרור עלויות גבוהות ומורכבות ישומית ניכרת

מדידה מבוססת נתונים קיימים

ניתן לבחון מנגנון למדידת תוצאות על בסיס נתונים הקיימים במערכת:

1. בחינת הדרדרות המטופלים בכל חברה בין רמת זכאות אחת לשנייה אל מול קצב הדרדרות ממוצע (לא מבוצעת בדיקה אקטיבית של המטופלים)

אפשרות זו עלולה לגרום לחברות למנוע מהמטופלים להגיש בקשות להחמרה בגמלה גם אם מצבם האובייקטיבי מצריך זאת. יש לציין כי היות והתשלום הוא שעותי, אפשר להעריך כי הרצון של החברות לספק יותר שעות יאזן את הניסיון של החברות למנוע מעבר המטופלים בין רמות הגמלה.

2. מעקב אחר אשפוז של מטופלים + טיפול ביחידות לרפואה דחופה

נתון זה נמצא בשימוש במדינות רבות כאשר מנסים לבחון השפעות של טיפול ביתי. ההנחה היא שטיפול ביתי יכול ואמור להקטין את הצורך באשפוזים, בטיפול ביחידות לרפואה דחופה ואף בצורך במעבר למסגרות מלאות (בתי אבות למיניהם)

3. מבחני תלות יזומים על בסיס מבחני התלות הנערכים ע"י הביטוח הלאומי למבקשים שינוי ברמת הגמלה

מדידה אקטיבית ומחייבת של כלל המטופלים פעם בשנה גם אם לא תכננו להגיש החמרה בזכאות הגמלה. אפשרות זו עלולה להביא לעלייה בקצב המעבר בין הרמות, אך לכאורה תנבע ממצב נצרכות אובייקטיבי של הזכאים

*קונסורטיום ללא מטרת רווח אשר ייצר תקן מדידה ובקרה על טיפול ביתי במטרה לעודד שיפור באיכות החיים של במטופלים ברחבי העולם וכן אפשרות להשוות בין מדינות ובין שירותים

שונים על מנת להשפיע על איכות השירות. <https://interrai.org/>

**Home care quality indicators based on the Resident Assessment Instrument-Home Care (RAI-HC): a systematic review

מנגנון המודל

דוגמאות קונקרטיות למדדי תוצאה אפשריים

interRAI

מדדי תוצאה אופציונאליים**

- שיפור ב-ADL
- שיפור/ירידה ב-IADL
- ירידה בעצמאות
- קושי בתקשורת (או ירידה/עליה בתקשורתיות)
- שיפור בשליטה בסוגרים
- פצעי לחץ
- ירידה קוגניטיבית
- ירידה/עליה במצב הרוח
- ריחוק חברתי
- שינוי בהרגלי היציאה מהבית
- פציעות
- אשפוזים וטיפולים בלתי מתוכננים
- שיפור בניהול הכאב
- ירידה במשקל
- חיסון שפעת

המודל האמריקאי

מתבסס על מנגנון המדידה של OASIS*

- טיפול במרפאות לרפואה דחופה
- אשפוז בלתי צפוי
- מדד מורכב "טיפול עצמי":
 - יכולת גילוח
 - יכולת התלבשות פלג גוף עליון
 - יכולת התלבשות פלג גוף תחתון
 - יכולת להתרחץ
 - יכולת להתפנות בצורה עצמאית
 - יכולת לאכול
- מדד מורכב "תנועתיות":
 - גישה למיטה
 - גישה לשירותים
 - תנועתיות כללית
- שיפור בקוצר נשימה
- ניהול צריכת תרופות
- שיפור בכאבים המפריעים לתנועה

Wagner et al. BMC Health Services Research (2020) 20:206

Page 7 of 12

Table 2 Characteristics of identified relevant quality indicators

Indicator	Measure type	Source	Valid	Reliable	Valid	Reliable	Valid	Reliable	Valid	Reliable
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL decline	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
IADL improvement	O	1	✓	✓	C	A	B	2-100		
ADL decline										

מנגנון המודל

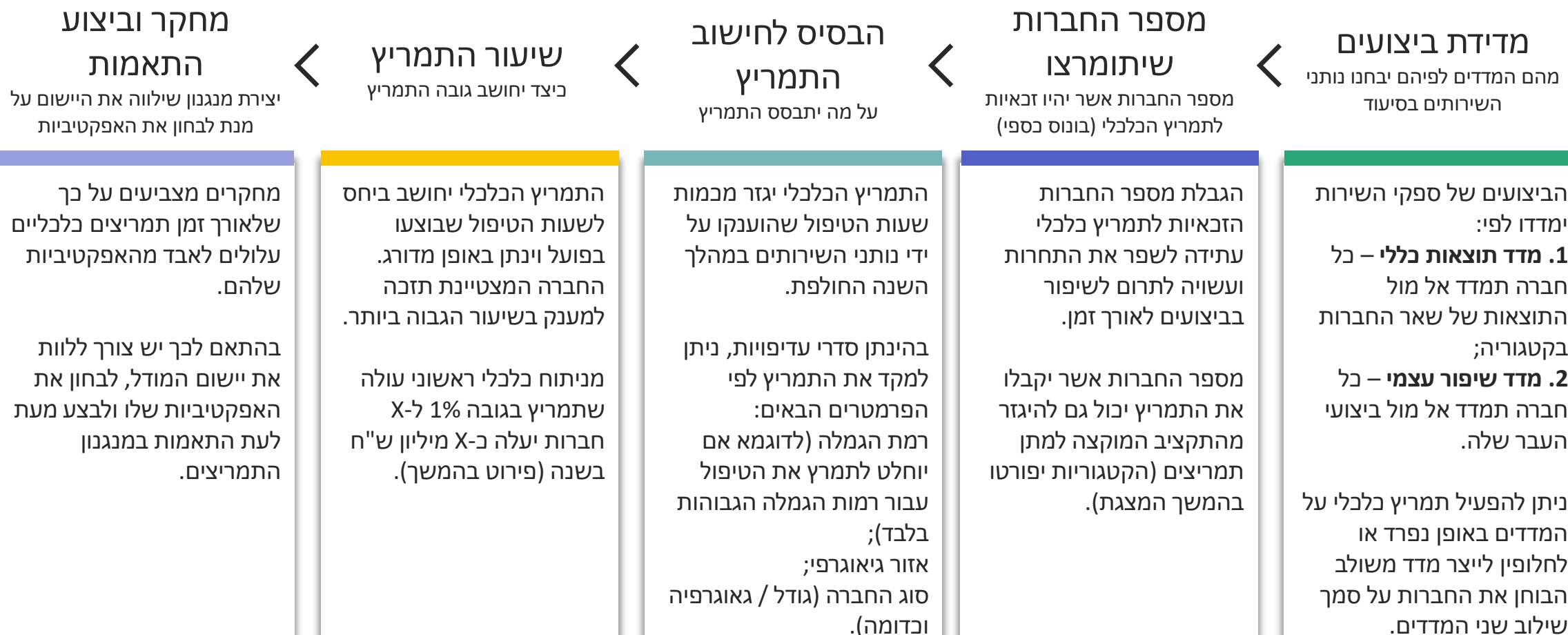


חלופות עבור גוף מבצע למדידת חברות הסיעוד*

1	הביטוח הלאומי	2	חברה חיצונית	3	חברות הסיעוד**
הסבר תהליך המדידה 	הביטוח הלאומי יהיה אחראי על מדידת החברות בהתבסס על מעבר בין רמות גמלה. המדידה תהווה עיבוי של המנגנון הקיים לקביעת רמת זכאות לגמלה ותתבסס על הפרוטוקול המיושם כיום בעת הגשת בקשה להחמרה בגמלה. טרם היישום של אפשרות זו יש לוודא כי מערך הבדיקות הנוכחי עומד בצרכים ובסטנדרט אותו התמריץ מנסה לעודד – טיפול דוחק תלות		חברה חיצונית אשר תפעל במרכז נפרד למכרז הסיעוד ותפקידה יהיה לבצע את המדידות השנתיות למטופלים של חברות הסיעוד. חברה זו יכולה לבצע הן את מבחני רמות הגמלה כפי שהם מבוצעים כיום או לחלופין מערכת של בדיקות אחרות אשר יוגדרו ע"י גורמי מקצוע. ניתן לשלב את החברה הזו עם מכרז הבקרה אשר הביטוח הלאומי מקדם בתחום הסיעוד		חברות הסיעוד יבצעו את המבדקים בעצמן וידווחו את תוצאותיהן לביטוח הלאומי. אפשרות זו מחייבת בקרה הדוקה ביותר אחר הנתונים שהחברות מעבירות לביטוח הלאומי (בין עם ע"י הביטוח הלאומי ובין עם ע"י חברת בקרה חיצונית). המדידה ע"י החברות חייבת להיעשות על ידי גורמים מקצועיים (עו"סים, מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים וכו')
מעורבות בקרה נדרש 	במצב בו הביטוח הלאומי מעבה את מערך הבדיקות שלו כך שהוא בודק את המטופלים בצורה שנתית, מערך הבקרה הנדרש מצומצם וכולל בעיקר בקרת על (פנימית או חיצונית) אודות תקינות ונאותות התהליך הכוללת בקרת טיב ההתנהלות של מערך הבדיקות, ויודא כי כל החברות נבדקות בצורה שווה וכי כלל המטופלים אשר אמורים להיבדק אכן נבדקו		הבקרה אחר חברת מדידה חיצונית תתבצע בעדיפות על ידי הביטוח הלאומי עצמו. במצב זה הבקרה תהיה מדגמית ותתבסס על מבדקים תקופתיים תוך הצטרפות לצוותי המדידה. כמו כן, החברה תידרש להגיש דוחות מסודרים על פעילויות המדידה, עמידה ביעדים, דוחות כספיים וכמובן את כל תוצאות המדידה של המטופלים עצמם		במצב בו חברות הסיעוד עצמן מבצעות את המדידה והבדיקה של המטופלים יש צורך במערך בקרה הדוק יותר. יתרה מכך, במצב זה יש לעשות הבדלה מוחלטת בין המדידה לצורך התמריץ ובין מבחני הזכאות לרמות הגמלה השונות. לא ניתן לתת לחברות עצמן לבצע את בדיקות הזכאות לרמות הגמלה. מערך הבקרה יהיה מבוסס על חברת בקרה חיצונית או על הביטוח הלאומי וידרוש תשומות גדולות יותר מהאפשרויות האחרות, אך יתכן ובחישוב הכולל יצא הזול ביותר

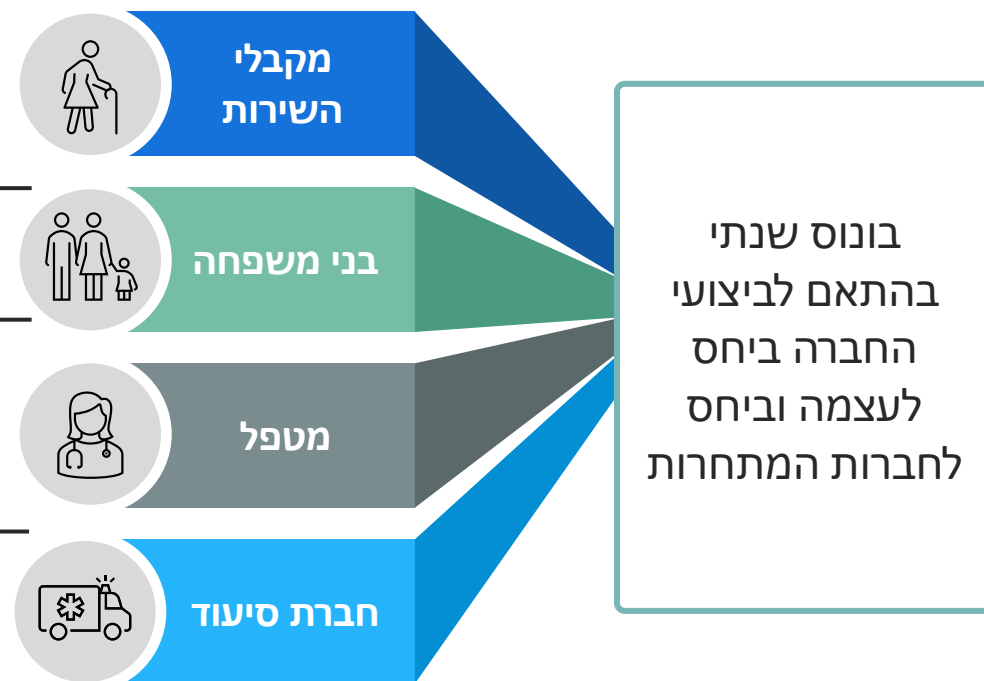
מנגנון המודל

פירוט התמריץ הכלכלי



השפעות

השפעות על 4 בעלי העניין



מקבלי השירות יהיו מודעים לתהליך המדידה (במצב בו המדידה מחושבת רק על סמך שינוי הגמלה שמתרחש בפועל, ללא מדידה אקטיבית, חלק זה פחות רלוונטי) והשפעה חיובית אפשרית היא חיבור שלהם לתהליך הטיפול וכן עידודם לחדש מנותני השירות טיפול ברמה גבוהה יותר חשוב לציין כי המטופלים לא יהיו חשופים לתוצאות המדידה של פתרון זה (מדד לציבור יופיע כפתרון בפני עצמו). מאידך, יתכן כי המטופלים יחששו פן חברות שונות לא יהיו מעוניינות לתת להם שירות אם יראו קצב הידרדרות גבוה ועלולים למנוע מעצמם את זכאותם האמיתית. בנוסף לכך, יתכן כי במידה וחלק מהמדידה תכלול שאלון שביעות רצון, החברות יפעילו לחץ על המטופלים דרך המטפלים על מנת להשיג ציונים גבוהים יותר

ללא השפעה

על אף שהמדידה היא אגרטיבית פר חברה, היא עשויה בסבירות מסוימת לשפר את הטיפול אותו יעניק המטפל ויכוון אותו לעבר דחיקת תלות ושיפור מצב המטופל, זאת עקב עצם המודעות לכך שהדבר נמדד ומשפיע על החברה בה המטופל עובד והלחצים שיופעלו מצד החברה על המטפלים. אולם, כפי שראינו בשלב מיפוי המצב הקיים*, לא ניתן להניח כי תמריצים כלכליים יחלחלו בצורה משמעותית מהחברה למטפלים ללא תמריץ ישיר. ישנה אפשרות כי החברות יבחרו לתמרץ מטפלות על טיפול מיטבי ללא קשר לתמריץ ישיר, אך היא אינה מוכרחת. מנגד, יתכן כי הלחץ על המטפלים יגדל בדגש על אספקטים שיש להם השפעה מקסימלית (בעלות מינימלית) על הדירוג כפי שייקבע, לעיתים תוך זניחת אספקטים מותאמים אישית לצרכים של המטופל הספציפי.

תגמול החברות על בסיס טיב הטיפול יביא בסבירות גבוהה, על פי תקדימים והמחקר בתחום, ליצירת תמריץ לשיפור השירות אשר מספקות החברות. החברות ישאפו לספק שירות מוכוון לעבר שיפור תוצאות ושיפור מצב המטופל וזאת על מנת לקבל דירוג אשר יזכה אותן במענק השנתי. הנתונים מארה"ב מראים כי ישנו שיפור בביצועי החברות לאורך זמן בעקבות שינוי התמריצים**.

צ'רי פיקינג: בחירת מטופלים אקטיבית. מצב בו החברה בוחרת רק במטופלים אשר ישרתו את הניקוד אותו מעוניינת לקבל.

מבנה התמריץ הנוכחי עלול לעודד מצב של **צ'רי פיקינג** של מטופלים אשר הסיכוי להידרדרותם הטבעית הינו נמוך יותר. על מנת למנוע מצב זה ניתן לפעול בכמה דרכים: 1. למנוע חוקית מהחברות לסרב לטפל במטופלים (לחברות ישנן דרכים לעקוף אפשרות זו) 2. לייצר ממוצע תמהיל מטופלים עקרוני אשר כל חברה נמדדת לפיו ובמידה והיא חורגת ממנו לאורך זמן יפגע הציון אותו קיבלה וכך יפגע או יישלל הבונוס אותו אמורה לקבל.



אפקטיביות התמריצים לאורך הזמן ודרכים לשימורה

- מבנה התמריץ מעודד אפקטיביות הן כלפי חברות אשר איכות הטיפול בהן טובה ויכולות להגיע לראש דירוג הטיפול ה'אובייקטיבי' והן כלפי חברות אשר ברגע נתון השירות שלהן פחות טוב אך ימדדו על השיפור העצמי. כך התמריץ ממשיך להיות אפקטיבי גם אם החברה אינה בראש הרשימה.
- נתוני הניסוי מארה"ב לא מראים ירידה באפקטיביות התמריצים לאורך 5 השנים האחרונות*.
- על מנת להבטיח את אפקטיביות התמריצים יש ללוות את היישום במחקר ארוך טווח על ההשפעות במצב המטופלים. בהתאם לתוצאות המחקר לאורך השנים ניתן יהיה לשנות את אופי התמריץ עצמו בכדי לדייק אותו לפעילות החברות בזמן נתון.
- לאור כניסתנו לתקופה אינפלציונית יש צורך לבצע הצמדה של התמריץ למדד רלוונטי (לדוגמה מדד המחירים לצרכן) בכדי להשאירו רלוונטי לאורך זמן ולמנוע את שחיקתו הריאלית.

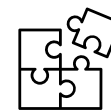


השפעות צולבות בשילוב פתרונות שונים

- **מדידת תפוקות למטפלות** – החברות עלולות לטעון כי כאשר אנו מגדירים למטפלות בדיוק מה התפוקות אשר הן נדרשות לבצע עם המטופל, אנו מונעים מהם את היכולת לתת שירות מותאם אשר ישפר בצורה טובה יותר את מצב המטופל, ובכך בעצם מונעים מהם להשיג תוצאות טובות בבדיקת התוצאות בדרכם שלהם.
- **פרסום מדדים לציבור** – במידה והמדד אשר יפורסם לציבור לא יהיה המדד עליו מקבלות החברות בונוס אלא יהיה מורכב ממדידה ונתונים שונים, אזי עלול להיווצר מצב בו החברות ייתעדפו תמריץ מסוים ויזניחו את השני (לאור מה שיחשבו שישרת אותם בצורה הטובה ביותר).

אופן יישום

עידוד תחרות במימוש הפתרון



ניקוד חברות על פי קטגוריית גודל מונע בעיה של יתרון לגודל

חלוקת החברות לקטגוריות על פי גודל החברה מבטלת במידה מסוימת את בעיית היתרון לגודל בחלוקת התמריץ. חברות קטנות לא יתחרו ישירות בחברות ענקיות וכך התמריץ יופעל על כלל המשק במידה שווה



מבנה התמריץ בהגדרתו מעודד תחרות

התמריץ בנוי כך שכל חברה נמדדת אל מול מתחרותיה ומקבלת ניקוד על תוצאות טובות ביחס לאחרות (וכן על שיפור עצמי). לאור כך, התמריץ מפעיל מימד תחרותי קבוע בין החברות היות ורק החברות אשר נמצאות בראש הדירוג יקבלו את הבונות השנתי



מדידה מתאימה לחברות חדשות בענף בכדי למנוע חסמי כניסה

על מנת למנוע חסם כניסה של חברות חדשות לענף יש צורך לקבוע את אופי המדידה המותאם לחברות חדשות וזאת על פי הנתונים אשר יאספו במהלך התקופה הראשונה של הפעלת התמריץ**



כניסה ויציאה של חברות מאחוזי התמריץ

נתוני הניסוי בארה"ב* מראים כי ישנה תנועה בין חברות הנמצאות בצד החיובי של התמריץ (מקבלות בונוס) לבין חברות הנמצאות בצד השלילי של התמריץ באופן קבוע. הדבר מצביע על כך שהתמריץ לא יוצר מלכודת עוני או מעודד רק חברות מסוימות להגיע לרף התמריץ

* <https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/09/2021-23993/medicare-and-medicaid-programs-cy-2022-home-health-prospective-payment-system-rate-update-home#h-122>

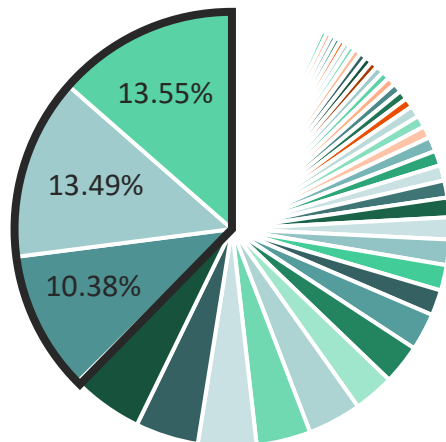
** במודל האמריקאי חברות אשר נכנסות לענף לאחר תחילת הפעלת שיטת התשלום החדשה לא נכנסות מיידית לדירוג אלא מקבלות זמן התאקלמות והתארגנות (בדרך כלל מדובר על התקופה שבין הכניסה לענף ובין תחילת השנה הפיסקלית הבאה). השנה המלאה שלאחר מכן מהווה את שנת הבנצ'מרק לחברה הספציפית ורק לאחריה היא נכנסת ומדורגת ביחס למתחרותיה.

על מנת לייצר תחרות מותאמת ושוויונית בין נותני השירותים במתן התמריץ, ניתן לייצר קטגוריות מובחנות עבור חברות בעלות מאפיינים דומים

תבחינים אפשריים בחלוקת הקטגוריות*:

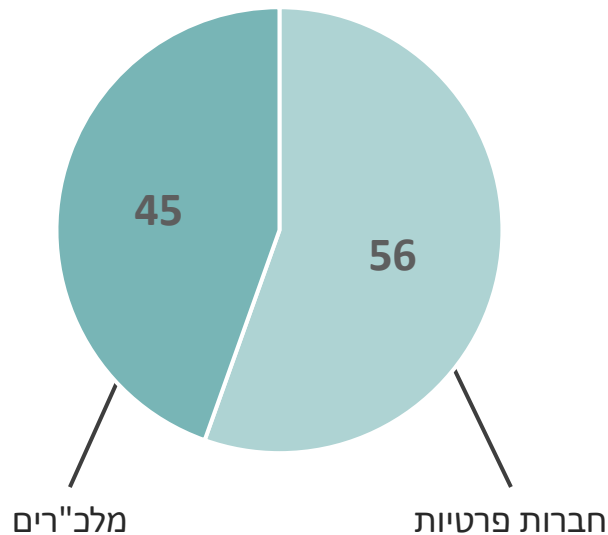
1. הבדל בין חברה פרטית למלכ"ר

2. הבדל בגודל** נותן השירות



כמעט 40% מכלל המטופלים מקבלים שירות מ-3 החברות הגדולות בענף

לחברות בעלות נפח פעילות שונה ישנן מגבלות תקציביות שונות המשפיעות על יכולתן להשקיע משאבים בשיפור השירות. יתרון של החברות הגדולות עלול להיות משמעותי



תמריצים כלכליים עשויים לפעול בעוצמות שונות על חברות אשר מטרתן למקסם רווח לעומת עמותות ומלכ"רים אחרים

נתונים מאפשרי יישום ניתוח נתונים לטובת סגמנטציה בין חברות



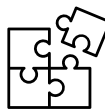
בכדי לייצר תמריץ אשר יהיה יעיל ביחס לכלל השוק ויצליח להשיג את הפעולה הרצויה, יש צורך בניתוח נתונים הן של נותני השירות והן של המטופלים והמטפלים.

כפי שניתן לראות בגרפים, השוני בין נותני השירותים השונים הינו גדול, הן מבחינת גודל החברה והשירותים הניתנים, והן מצד סוג הספק (מלכ"ר/פרטי). שינויים אלו עלולים לגרום להטיה של התמריץ כך שהוא יעבוד בצורה חזקה מדי או חלשה מדי על ספקים שונים. יתרה מכך, על מנת שהמדידה תאפשר לבחון בצורה מדויקת שיפור השירות ודירוג החברות, יש צורך להשוות בין ספקים הדומים במאפייניהם הבסיסיים.

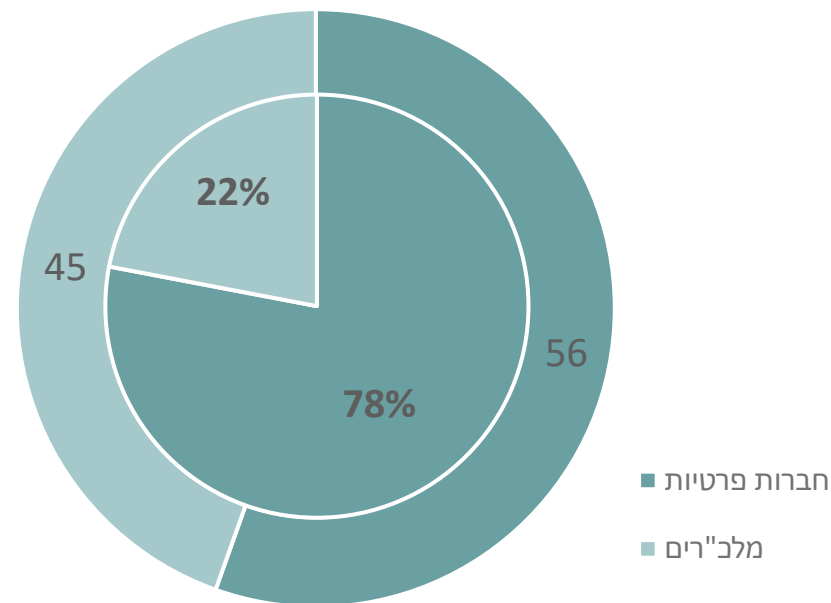
ניתוח הנתונים בשלב זה מוגבל בשל מחסור בנתונים רב-שנתיים.

נתונים מאפשרי יישום

ניתוח נתונים לטובת פילוח בין חברות*



שיעור המטופלים המקבלים שירות
מחברות פרטיות לעומת מלכ"רים



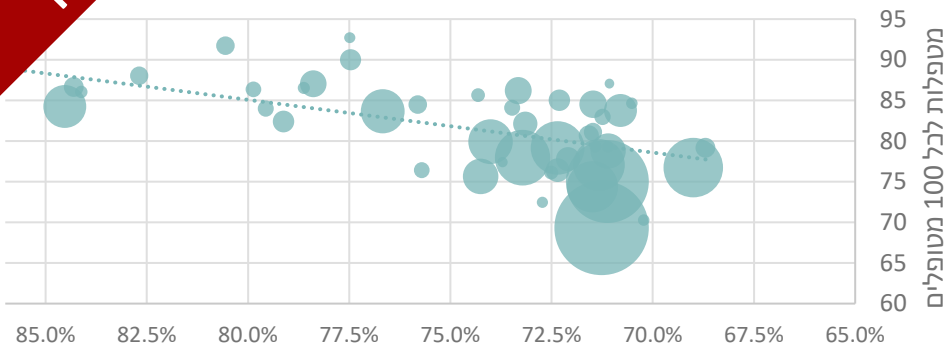
על אף היותם כ-45% מכלל נותני
השירותים, מלכ"רים מספקים שירות
רק ל-22% מהמטופלים

כמות מטופלים	מס' חברות	מס' מלכ"רים	סה"כ
עד 350	9	32	41
350 עד 1,000	17	8	25
1,000 עד 10,000	25	4	29
מעל 10,000	5	1	6

ניתן לראות כי מלכ"רים מהווים את עיקר החברות הקטנות והבינוניות ואילו החברות הפרטיות מהוות את עיקר החברות הגדולות והגדולות מאוד.

ישנה חלוקה ברורה בין שני סוגי ספקים – חברות פרטיות ומלכ"רים. לאורך חיי המודל והתמריץ ניתן לבצע מדידות ולבחון האם קיימת שונות בהתנהגות של הספקים השונים אשר מקורה בחלוקה בסיסית זו. ניתן לשקול אפשרות של חלוקה בין שני הסוגים בעת חישוב המדד לחלוקת התמריץ

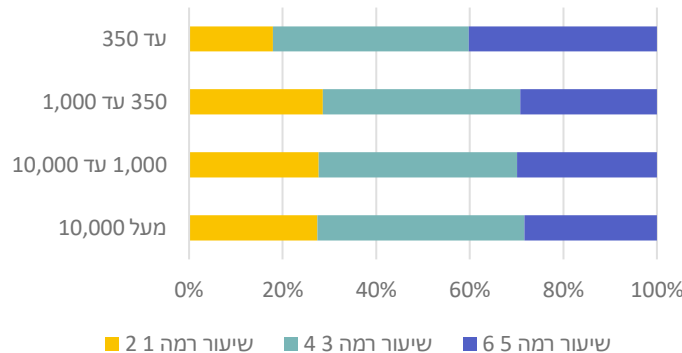
כמות המטופלים לכל מטפלת אל מול שיעור ניצול הגמלה



מיצוי פוטנציאל שעות טיפול למטופל (כמה שעות טיפול מומשו מסך הזכאות)

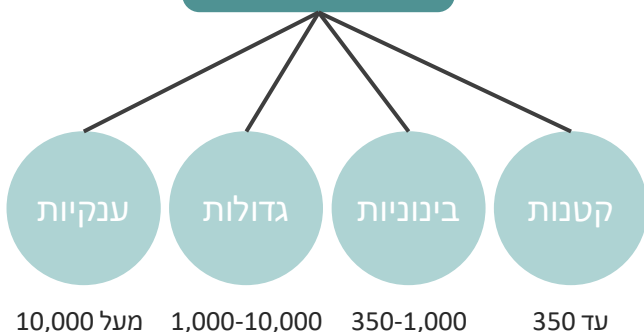
הגרף מראה כי ישנה התנהגות שונה בקרב החברות כך שבחברות הגדולות יש בממוצע יותר מטופלים לכל מטפלת, וכן שניצול הגמלה לקבלת שירותי סיעוד נמוכה יותר (יכול לבוע ממספר סיבות, לא כולן קשורות בחברה)

תמהיל מטופלים בחברות פרטיות, לפי רמות גמלה



ניתן לראות כי לחברות הקטנות תמהיל מטופלים שונה משאר החברות כך שהן מטפלות ביותר מטופלים קשים באופן יחסי

חברות פרטיות



לאור ההבדלים הנובעים מגודל החברה ולאור הנתונים לעיל המציגים שוני בהתנהגות החברות, להלן חלוקה של החברות הפרטיות בשוק הסיעוד ל-4 קטגוריות גודל אשר יכולות לשמש למדידת השירות וקביעת גובה התמריץ

נתונים מאפשרי יישום ניתוח נתונים לטובת סגמנטציה בין חברות



חלוקת החברות הפרטיות לפי גודל

הבדלים בגודל החברה משפיעים בצורה ניכרת על התנהלות החברה במתן השירותים וברגישות לתמריץ בגובה מסוים.

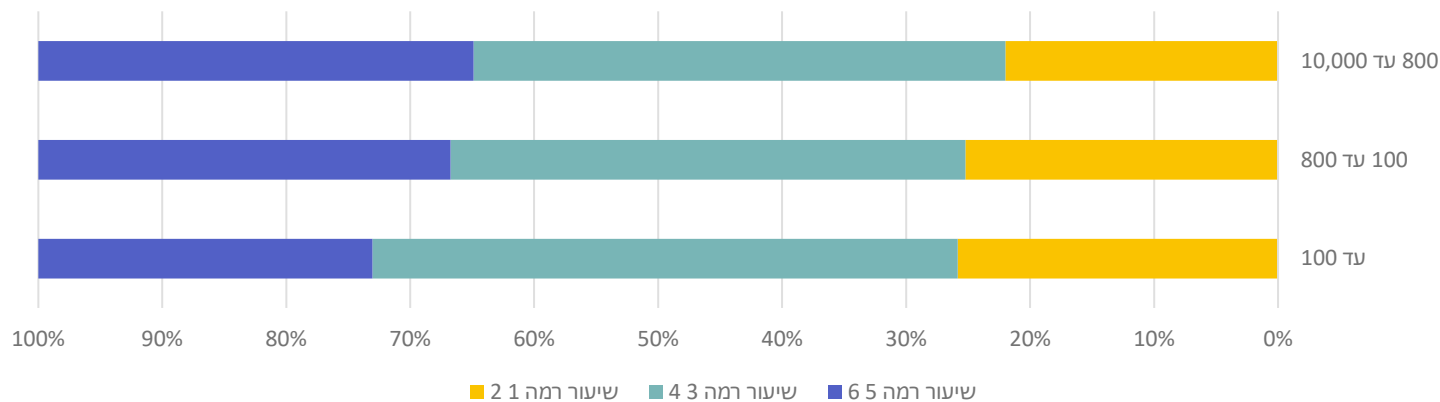
ראשית, לחברות גדולות יותר ישנה בדרך כלל יכולת מוגברת בהשקעת כספים לטובת שיפור השירות, וזאת לעומת חברות בעלות מחזור עסקים קטן יותר.

שנית, חברות גדולות מפעילות מערך מטפלים ועובדים גדול יותר, והשפעה על התנהלותו המקצועית יכולה להיות מורכבת יותר

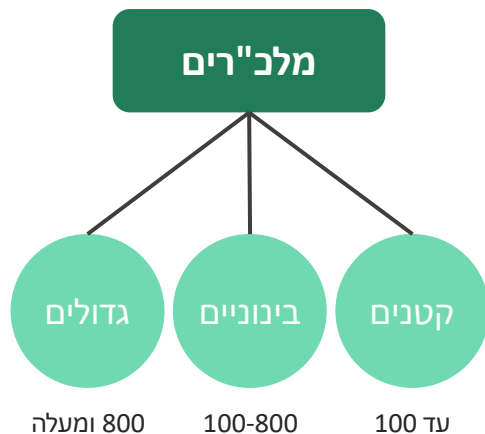
שלישית, ניתוח השוק מראה כי ישנו יתרון לגודל החברה כך שלחברות הגדולות יש בפער ניכר יותר מטופלים מהחברות הבינוניות והקטנות

לאור אלו נראה כי ישנה חשיבות לפילוח החברות לקטגוריות מדידה ותמריץ נפרדות ע"פ הגודל

תמהיל מטופלים במלכ"ר, לפי רמות סיעוד*



ניתן לראות כי לספקים הקטנים תמהיל מטופלים שונה משאר הספקים כך שהם מטפלים בפחות מטופלים מרמות 5+6 באופן יחסי



800 ומעלה

100-800

עד 100



לאור ההבדלים הנובעים מהגודל ולאור הנתונים לעיל המציגים שוני בתמהיל המטופלים, להלן חלוקה של המלכ"רים הפועלים בשוק הסיעוד ל3 קטגוריות גודל אשר יכולות לשמש למדידת השירות וקביעת גובה התמריץ

נתונים מאפשרי יישום

ניתוח נתונים לטובת

סגמנטציה בין חברות



חלוקת מלכ"רים לפי גודל

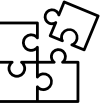
גם במלכ"רים, כפי שהוצג קודם לכן לגבי חברות פרטיות, הבדלים בגודל החברה עשויים להשפיע על התנהלות החברה במתן השירותים וברגישות לתמריץ בגובה מסוים.

לאור האמור בשקף הקודם נראה כי ישנה חשיבות לפילוח המלכ"רים גם הם לקטגוריות מדידה ותמרוץ נפרדות ע"פ הגודל

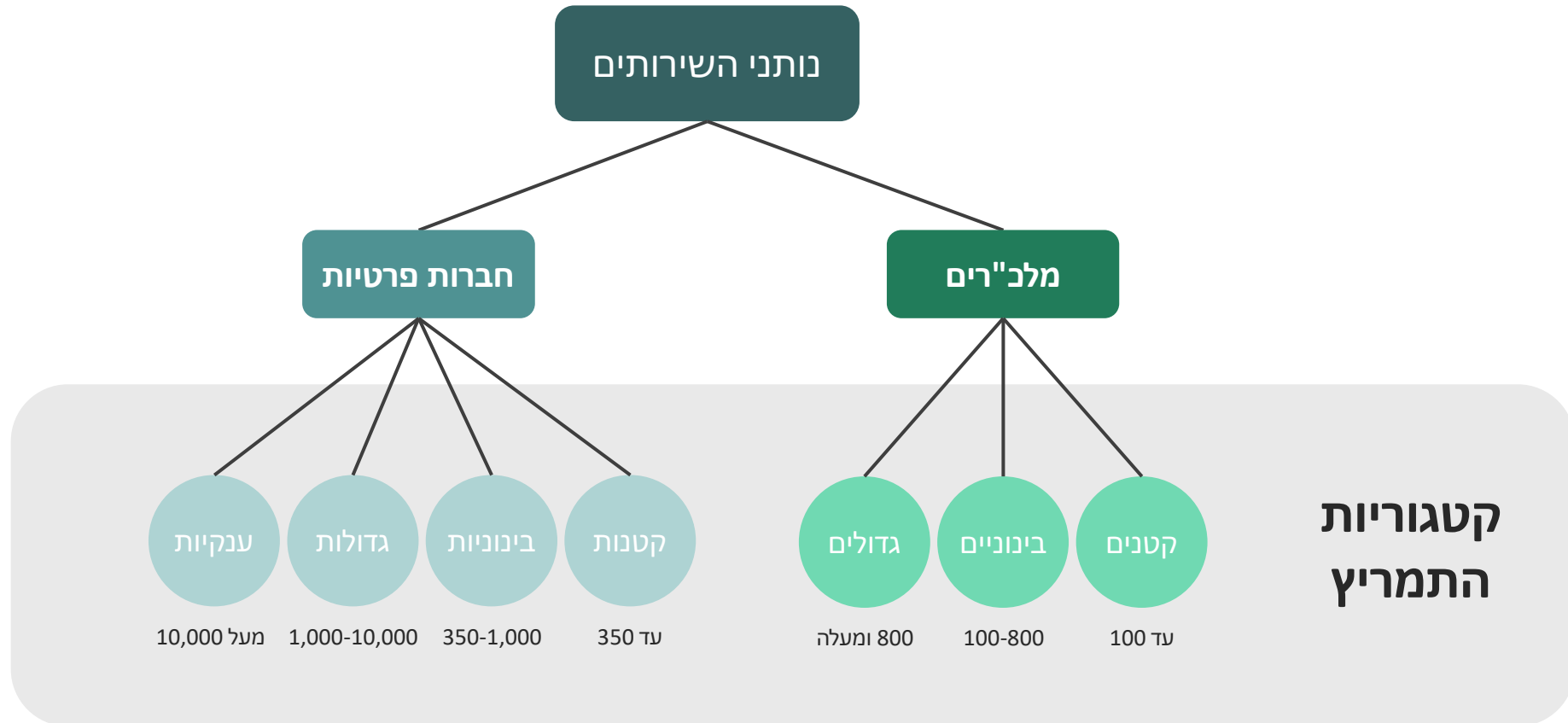
לעומת חברות פרטיות, בהם השינוי המשמעותי היה סביב חברות המספקות שירות לכ350 מטופלים, נראה כי במלכ"רים נכון יותר לחלק על פי גדלים אחרים במקצת, וזאת על מנת לבצע חלוקה מותאמת יותר למלכ"רים

* ישנו מלכ"ר אחד המספק שירות ל33,447 ונחשב לספק גדול מאוד. לאור כך שהינו בודד בקטגוריה שלו, יש לבחון האם נכון לצרפו לחברות הפרטיות הענקיות או למלכ"רים הגדולים

אופן יישום



סיכום אפשרויות חלוקת נותני השירותים לקטגוריות



141 מיליון דולר

חיסכון למשלם המיסים המהווים כ-0.2%
מכלל הMEDICAID, וזאת ביחס לשיטת
התשלום הקודמת

4.6%

השיפור הממוצע בביצועי
הספקים (ציון הTPS השנתי)
לאורך תקופת הניסוי

מהלך הניסוי ושיטת הדירוג והתשלום לספקים:

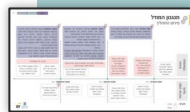
שנת התשלום (2018)

בשנת התשלום מבצע השינוי
בתשלום לחברות לאור הדירוג
הראשי שלהם. הדירוג הינו הציון
המשוכלל הגבוה מבין שני
המדדים שנבדקו בשנת הביצוע.
בהתאם לדירוג החברה על ביצוע
בשנת הביצוע ישנה נוסחה אשר
מחשבת את הבונוס או הקנס
אשר מקובלת החברה.

שנת הביצוע (2016)

בשנת הביצוע נמדדות החברות
על ביצועיהן באופן זהה לשנת
הבסיס, אך הציונים אשר ניתנים
הינם ביחס לשני מדדי יחוס
שונים:

1. מדד שיפור עצמי: השיפור
בביצועי החברה ביחס
לביצועיה בשנת הבסיס
2. מדד ביצועים כללי: ביצועי
החברה לעומת מדד היחוס
הקטגורי של כלל החברות
משנת הבסיס



שנת הבסיס (2013-2015)

שנת הבסיס נועדה לייצר מדידות
סף ומצע ברור למדידות
ולביצועים של השנים הבאות.
בשנת הבסיס נמדדת כל חברה
על ביצועיה באופן מלא אך
למדידה זו אין עדיין השלכות
כלכליות על החברה באופן ישיר.
בסוף שנה זו מבוצע חישוב של
המדדים ויוצרים את הממוצעים
ואת הציונים אשר ישמשו
בהמשך כמדדי יחוס לביצועי
החברות

תימוכין קונקרטיים מהעולם

מודל התמרוץ של הCMS

Home Health Value-Based Purchasing
(HHVBP)
ארה"ב

ב-2016 התניע הCMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) ניסוי אשר
התמקד בשינוי שיטת התשלום לספקים אשר
מספקים טיפול ביתי לזכאי הMedicaid
האמריקאי.

הניסוי כלל את כלל הספקים המורשים ב-9
מדינות שונות בארה"ב והתקיים מ-2016 ועד
2021.

תוצאות הניסוי הראו שיפור הן באיכות הטיפול
אשר הציגו הספקים השונים לאורך השנים והן
ירידה בהוצאה הציבורית על בריאות של
המטופלים של אותן החברות.

כתוצאה מניסוי זה, הוחלט להרחיב את
התוכנית כך שתכלול את כלל המדינות
והספקים בארה"ב, וזאת החל משנת 2022.

תימוכין קונקרטיים מהעולם

מודל התמרוץ של ה-CMS

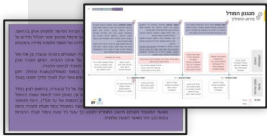
מנגנון המדידה, שיטת הדירוג וחישוב התשלום

חישוב התשלום



- חישוב התשלום מתבצע על סמך ציון ה-TPS של כל חברה ובשכר של התשלום אותה אמורה לקבל על שירותי השנה החולפת
- החברות יכולות לקבל אחוזי תוספת לתשלום התשומתי או הפחתה מתשלום זה באותו השיעור. כלומר, החברה אשר נמצאת בראש הרשימה תקבל 5% תוספת ולחברה אשר נמצאת בתחתית הרשימה יורידו 5%. החברות הממוצעות נשארות עם תשלום ע"פ סכום הבסיס. התפלגות הבונוס הינה נורמלית כך שבמרב המקרים הסכום הכולל להפעלת התמריץ מתאפס.

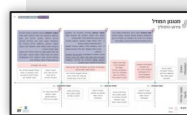
	(C1)	Step 1 (C2)	Step 2 (C3)	Step 3 (C4)	Step 4 (C5)	Step 5 (C6)	Step 6 (C7)	Step 7 (C8)
	Total Performance Score (TPS)	Prior Year Payment	Unadjusted Payment Amount 5% x (C2)	TPS-Adjusted Payment Amount (C1/100) x (C3)	Linear Exchange Function (LEF) Ratio Total (C3)/ Total (C4)	Final TPS-Adjusted Payment Amount (C4) x (C5)	TPS-Adjusted Payment Percentage (C6)/(C2)	Final TPS- Adjusted Payment Percentage (C7) -5%
HHA 1	38	\$100,000	\$5,000	\$1,900	1.931	\$3,669	3.669%	-1.331%
HHA 2	55	\$145,000	\$7,250	\$3,988	1.931	\$7,701	5.311%	0.311%
HHA 3	22	\$80,000	\$4,000	\$8,800	1.931	\$16,995	2.124%	-2.876%
HHA 4	85	\$653,222	\$32,661	\$27,762	1.931	\$53,614	8.208%	3.208%
HHA 5	50	\$190,000	\$9,500	\$4,750	1.931	\$9,173	4.828%	-0.172%
HHA 6	63	\$340,000	\$17,000	\$10,710	1.931	\$20,683	6.083%	1.083%
HHA 7	74	\$660,000	\$33,000	\$24,420	1.931	\$47,160	7.146%	2.146%
HHA 8	25	\$564,000	\$28,200	\$7,050	1.931	\$13,615	2.414%	-2.586%
		\$172,611	\$89,379			\$172,611		
		Sum C3	Sum C4			Sum C6		



שיטת הדירוג



- מדד ה-TPS (Total Performance score)** משכלל את נתוני שלושת המערכים לכדי ממד הערכת איכות אחד איתו ניתן יהיה לחשב את אחוז התוספת המגיע לכל חברה בהתאם לביצועיה. החברות מחולקות לשתי קטגוריות לפי כמות 'תקופות הטיפול' אשר העניקו באותה השנה.
- כל מדד מחושב בפני עצמו לכל חברה. המדד מחושב אל מול המדד היחסי אשר נקבע בהתאם לקטגוריה של החברה (גודל החברה לפי כמות 'שעות טיפול') בשנת היחוס וכן אל מול השיפר של החברה ביחס לעצמה בשנת היחוס. הציון הגבוה מבין השניים מחושב כציון של המדד לחברה באותה השנה.
- כלל המדדים משוכללים לכדי מדד אחד, TPS, אשר מציין את השיפור או הירידה הכללית של החברה באיכות השירות אותו נתנה באותה השנה לכלל המטופלים שלה.

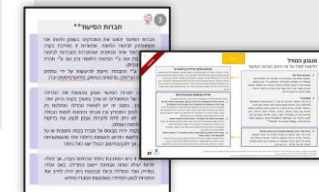


מנגנון המדידה



המדידה של השירות אשר ניתן למטופלי Medicaid מבוסס על שלושה מערכים נפרדים המשלימים אחד את השני.

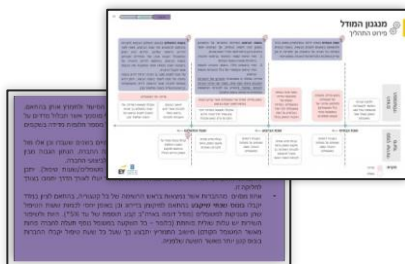
- OASIS:** תקן המדידה לשירותי טיפול ביתי אשר נמצא בשימוש המדיקאייד ומדווח באופן שוטף ע"י כלל הספקים האמצעות טפסים רשמיים ומסודרים הממולאים ע"י אחיות מוסמכות (או גורמי טיפול מוסמכים אחרים כדוגמת פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק וכו)
- The Home Health Care Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (HHCAHPS) סקר אשר נועד למדוד את שביעות רצון המטופלים אשר מקבלים טיפול ביתי מספקים של המדיקר.
- דיווח עצמי של החברות על 3 מדדים ספציפיים - החברות מקבלות ניקוד על עצם הדיווח ולא על המהות המדווחת



תימוכין קונקרטיים מהעולם

מודל התמרוץ של ה-CMS

נתונים נוספים למודל



1

הניסוי לווה במחקר מעמיק ומתמשך על תוצאותיו כך שניתן היה ללמוד מלקחי המודל ולבחון את השפעתו ואת יתרונותיו על פני השיטה הקיימת.

2

אחוז תוספת/הפחתת תשלום של מקסימום 5%: נתוני הניסוי הראו כי הסכום האפקטיבי נשאר סביב 5% תוספת/הפחתה ולהעלאה של האחוז אין תרומה ניכרת בתוצאות השירות. בהרחבת המודל האמריקאי הוחלט על 5% שינוי בתשלום כלפי מעלה ומטה. במצב זה כ-95% מכלל נותני השירות קיבלו שינוי של עד 3% בלבד.

<https://www.federalregister.gov/d/2021-23993/p-403>

3

על מנת לאפשר לחברות להסתגל לשיטת המדידה והתמריץ, יש לתת שנה מלאה של עבודה שוטפת טרם התחלת הבדיקה עליה תיבחן החברה (כאשר מדובר בחברות חדשות)

<https://www.federalregister.gov/d/2021-23993/p-413>

4

מערכת הדירוג במודל האמריקאי מתחשבת במטופלים שונים ובסיכויי השיפור שלהם על מנת שלא לפגוע בדירוג חברות המטפלות באוכלוסייה קשה יותר – נוסחאות ניהול הסיכונים (שינויים במדדים לאור תמהיל מטופלים ואזור) שלהם עובדות לטענתם בצורה טובה – לא נראה שיש השפעה על נגישות הטיפול

<https://www.federalregister.gov/d/2021-23993/p-475>

5

בחלוקת הספקים לקטגוריות ע"פ גודל 93% מהחברות נמצאות בקטגוריה של החברות הגדולות ואילו רק 7% נמצאות בקטגוריה של החברות הקטנות

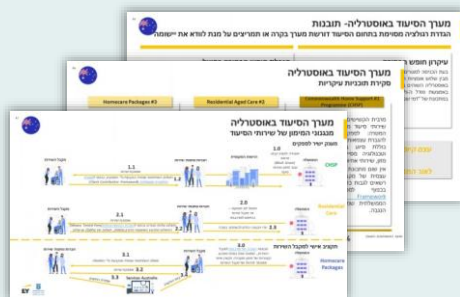
תימוכין קונקרטיים מהעולם

מודלים ומחקרים נוספים שנסקרו

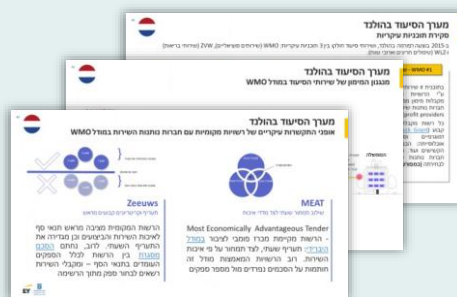
מודלים

במהלך העבודה נסקרו מודלים נוספים (כחלק משלב הבנצ'מרק)

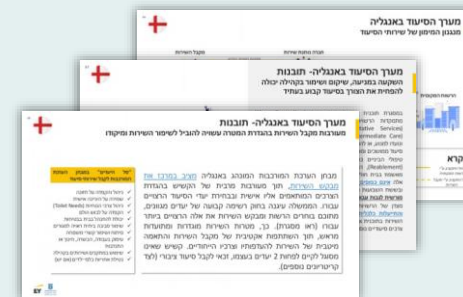
אוסטרליה



הולנד



אנגליה



כמו כן, נסקרו
מחקרים ומאמרים
ביניהם:

יתרונות וחסרונות במימוש הפתרון

חסרונות

ידרוש הקמת מערך מדידה ובקרה מורכב (בין עם בתוך הביטוח הלאומי ובין אם מחוצה לו)

עלול לעודד צ'רי פיקינג של מטופלים על ידי נותני השירות אשר ירצו להעלות את נתוני ההצלחה שלהם

עלול לגרום לחברות למנוע ממטופלים להגיש בקשות להחמרה ברמת הגמלה גם אם זקוקים לכך

תמריץ זה מהווה שינוי משמעותי ומהותי בגמלה אשר כולל בניית מערך מדידת ותשלום על תוצאות. שינוי זה עלול להיות מורכב ליישום

יתרונות

התמריץ מעודד את השוק הפרטי לעשות שימוש במשאביו באמצעות מדידת תוצאות ולא תפוקות/תשומות

התמריץ צפוי לעודד הן נותני שירות גדולים והן נותני שירות קטנים

תחת תנאים מסוימים יכול לאפשר השוואת איכות הטיפול ותוצאותיו למדינות אחרות בעולם

מודל דומה בארה"ב שצבר כמה שנות ניסיון והראה הצלחה במדדים השונים

מעודד חברות לשיפור מתמיד גם אם נמצאות בשנה מסוימת בראש הדירוג

04. מדידת חברות הסיעוד על איכות הטיפול באמצעות מדידת תפוקות ותשומות

ניתוח מעמיק לחלופת הפתרון

מחקר אשר נערך בנוגע לטיפול רפואי ראשוני מצא כי אין מספיק ראיות אשר יתמכו ביעילותם של תמריצים כלכליים לשיפור השירות לאורך זמן:

“There is insufficient evidence to support or not support the use of financial incentives to improve the quality of primary healthcare provision”

An overview of reviews evaluating the effectiveness of financial incentives in changing healthcare professional behaviours and patient outcomes*

הערה אודות המחקרים ומקרי המבחן

בשנים האחרונות החלו לישם תוכניות עם תמריצים ומנגנוני תשלום אשר מבוססים על תפוקות או תוצאות בתחומי הבריאות (וזאת לעומת תשלום מבוסס תשומות בלבד כפי שהיה נהוג עד כה).

מסקירת מחקרים שנערכו במגוון מדינות אשר יישמו תוכניות ומנגנוני תשלום מסוג זה עולה כי:

אין מובהקות מחקרית אודות יעילותם של תמריצים כלכליים מבוססי תפוקות לשיפור איכות הטיפול בתחומי הבריאות לאורך זמן

אף על פי כן,

לא נמצאו מחקרים אשר קראו לחזור לשיטת התשלום מבוססת תשומות לחלוטין

אלא לנסות ולמצוא את המודל האידיאלי ויעיל ביותר תוך דיוק מנגנוני התמרוץ והמדדים.

*Flodgren G, Eccles MP, Shepperd S, Scott A, Parmelli E, Beyer FR. An overview of reviews evaluating the effectiveness of financial incentives in changing healthcare professional behaviours and patient outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2011:CD009255

על אף האמור לעיל, גם מחקרים אשר אינם מצביעים על אפקטיביות ברורה ממליצים להמשיך ולנסות מנגנוני תמרוץ ומדידה שאינם מבוססי תשומות

Successes and Failures of Pay for Performance in the United Kingdom**

בשנת 2004 הוצג באנגליה מנגנון תשלומים חדש לרופאי משפחה אשר משלב מדדי תפוקות שעל בסיסם מחושב 25% מהתשלום לרופא. במהלך למעלה מ-10 שנות פעילות של המנגנון, לא נצפה שינוי מתמשך באיכות השירות הניתן לאזרחים בצורה. יתרה מכך, נראה כי למנגנון היו השפעות שליליות על תהליכי האבחון והטיפול של הרופאים. אף על פי כן ברור לקובעי המדיניות ולעורכי המחקר כי **נכון להמשיך ולנסות ולטייב שיטות תשלום אלו** היות והינן בפוטנציאל יעילות יותר ויוכלו להביא לשיפור באיכות

Value-based providers' payment models: understanding where and under which conditions they work*

מסקירה רוחבית אשר הופיעה כחלק מהמסמך של OECD אודות מערכות תשלום מבוססות ערך (תפוקות ולעיתים תוצאות) **נראה כי הממצאים מעורבים ואין הוכחה חד משמעית ליכולתם לשפר את איכות השירות**. נראה כי ישנה שונות גדולה מאוד בין המודלים השונים אשר יושמו ברחבי העולם וכן שונות גדולה בהקשר הטיפולי-חברתי-כלכלי אשר משפיע גם הוא על התוצאות במודל והתמריץ. על אף זאת, כפי שראינו בשקפים הקודמים, **ה-OECD קורא ליישם מנגנוני תשלום שאינם תשומתיים** מתוך הנחה כי אם יבוצעו בצורה טובה יוכלו לשפר את השירות הניתן לאזרח

Pay for performance can be used to improve the quality of care, **but it is not a “magic bullet”** and needs to be combined with other quality-improvement initiatives to produce sustained improvements.

66

The success of value-based provider payment models is mixed and ranges from no changes to standard delivery of care, or higher expenditures without quality improvements, to improved quality and lower health expenditures (Rutledge et al. 2019)

99

מחקרים ומקרי מבחן מהעולם

מבחר המלצות לדוגמה מתוך דוח OECD

קווים מנחים לגיבוש מנגנוני תשלום מבוססי תפוקות בתחום הבריאות ע"פ ה-OECD*:

חשוב לציין כי ההמלצות במסמך סויגו היות וטרם נמצאו מספיק עדויות תומכות בשיטות התשלום החדשות

השתתפות כלל הספקים



יש לוודא כי כלל הספקים הינם שותפים פעילים בשיטת המדידה והתמרוץ וזאת על מנת להשיג שיתוף פעולה מלא אשר יאפשר התגברות על מכשולים נוספים באסיה הקטנה

ניהול סיכונים



יש לוודא כי הסיכון (והסיכוי) אשר אליו חשופי הספקים השונים הינו זהה ושוויוני. כלומר, יש לייצר מנגנון אשר יתחשב באופי האוכלוסיה אשר מטופלת ע"י הספקים כך שהמגמות יהיו זהות בקרב מקבלי ונותני השירות

קביעת גובה התמריץ



יש לקבוע תמריץ אשר יהיה משמעותי מספיק על מנת ליצר דחיפה של בעלי העניין לעבר איכות השירות שאנו מעוניינים לקדם. מאידך, יש לשים לב כי לא מעניקים תמריץ גבוה מדי בצורה שאינה נצרכת ואשר יגדיל את ההוצאה הציבורית הגדולה גם כך

ניסוי תחילה



היות והשלכות שינוי מערכת התשלום או המדידה אינם תמיד צפויים וברורים לעין, יש צורך והמלצה להתחיל מניסוי מקומי או לאומי לזמן מוגבל, וזאת עד אשר יתקבלו תוצאות ברורות אשר יעודדו את המשך היישום

דרישות מיחשוביות ומערכות IT



מנגנון ומודל תמריצים המבוסס על מדידה הינו מורכב מבחינה תקשובית ודורש השקעה בתשתיות אלו. על מנת לאפשר מדידה רציפה, מהירה ושיטתית של כלל הספקים יש להשקיע בתחום זה את המשאבים הנדרשים

מנגנון המודל

מבט על



אופן תמרוץ



מדידת החברות על תפוקות שירות אשר מסופקות לזכאים. מדידת החברות יכולה להתפרסם כדרוג (מדידה כתמריץ בפני עצמו) או כחלק מתמריץ כלכלי

תדירות



תלוי במה ימדד, אך במרבית המקרים אחת לשנה. החישוב הסופי והניקוד יעשה אחת לשנה

קהל יעד



חברות הסיעוד/ספקי השירות

- על מנת למדוד את איכות הטיפול אשר מקבלים הזכאים מספקי השירות, ובהינתן העובדה שמצב המטופלים יכול להשתנות ממגוון סיבות רחב, פתרון זה יתמקד במדידת תשומות ותפוקות הטיפול של הספקים השונים.
- מדידת ספקי השירותים תתמקד במספר מאפיינים אשר יכולים להעיד על טיב השירות שמקבלים הזכאים לגמלת הסיעוד. יש צורך לגבש צוות מקצועי (כפי שנראה בהמלצות בהמשך) אשר יגבש את רשימת התפוקות הנמדדות
- הבחינה של הספקים תתבצע בצורה רציפה לאורך השנה או בנקודת זמן אחת זאת בהתאם לתשומה או לתפוקה שתבחן.
- ספקי השירות יזכו לניקוד בגין כל תפוקה באיכות גבוהה שנמדדה כך שכל שהספק משקיע בשירות טוב מקצועי ועשיר יותר הוא יזכה לניקוד גבוה יותר.
- לפתרון זה ניתן לצוות גם תמריץ כלכלי אשר יפעל בצורה דומה לזה המוצע בפתרון אשר דן במדידת תוצאות, רק עם צורת מדידה שונה.

פירוט תהליך המדידה ברמת על

מקבלי השירות עוברים שאלון הערכת שירות אחת לשנה/חצי שנה ע"י מעריך חיצוני

הספקים מעבירים דיווח שוטף אודות תשומות ותפוקות שימדדו

אחת לשנה מחושב המדד (בחלוקה של הספקים לקטגוריות)

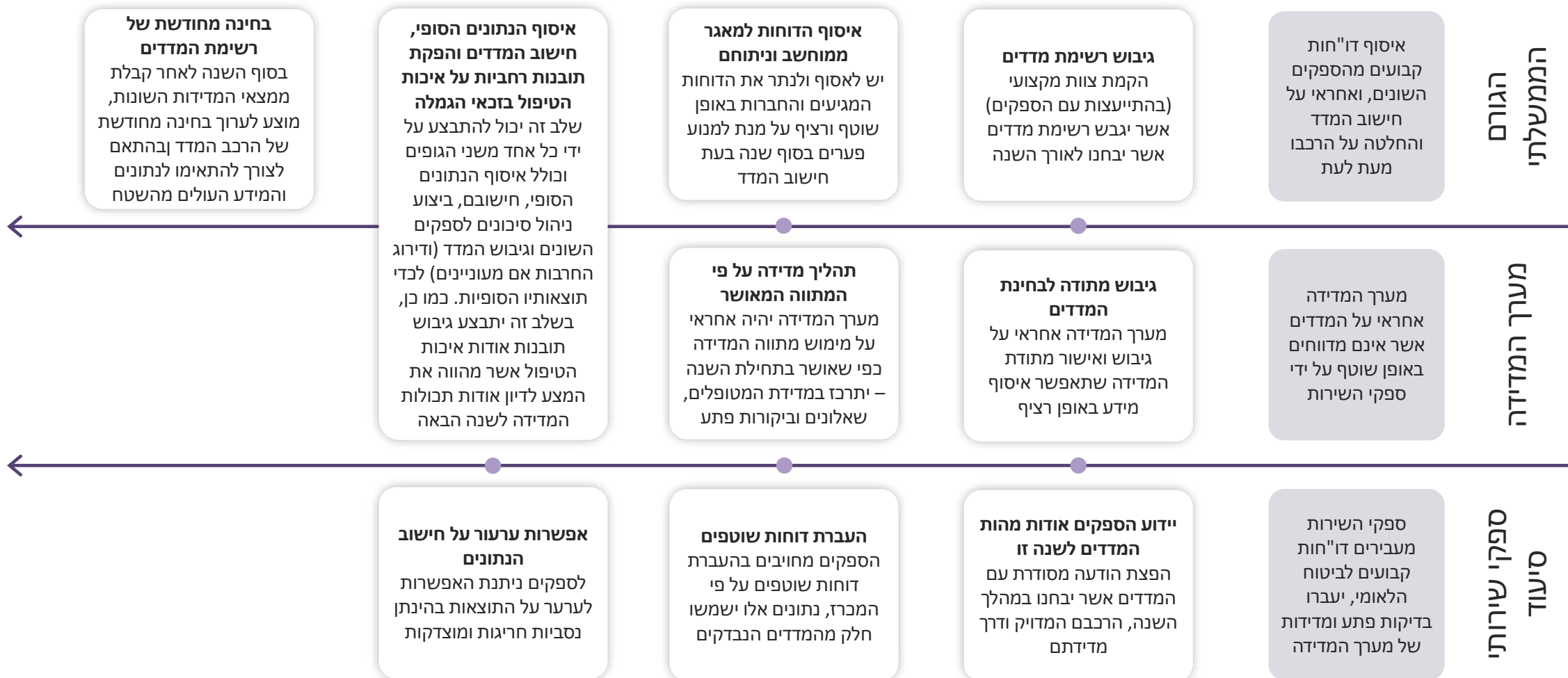
ניתן להפעיל תמריץ כלכלי בהתאם לתוצאות המדידה או לפרסמו לציבור

בכל סוף שנה נעשית בחינה מחודשת של המדדים ועדכונם בהתאם ללקחי השנה החולפת

מנגנון המודל



פירוט תהליך המדידה ומנגנון החישוב – תהליך שנתי גנרי



מנגנון המודל

בניית פיילוט למדידת איכות הטיפול והשירות



1



2



3



4

גיבוש רשימת מדדים
רחבה ממנה ניתן לבחור
מדדים לסעיפי הפיילוט

כדי לאפשר יישום מהיר יחסית
של הפיילוט **מוצע שהמדדים**
יורכבו מנתונים הנאספים כבר
כיום באופן שוטף ע"י החברות,
המוסד לביטוח לאומי או כל גורם
אחר (כדוגמת אחוז מטפלות
מוכשרות, כמות עובדים
מקצועיים מעבר לתקן ועוד).
לאחר ניתוח נתונים משלב
הפיילוט ניתן יהיה להרחיב את
המדידה לנתונים אשר אינם
נאספים כיום באופן שוטף.

גיבוש צוות אשר יהיה אמון
על בחירת המדדים
הספציפיים לפיילוט

על צוות המדדים לכלול גורמי
מקצוע טיפוליים ורפואיים,
גורמים מטעם המוסד לביטוח
לאומי ואנשי דאטה אשר
מכירים את הגמלה ואת הנתונים
הנאספים כיום ומהימנותם.

שימוש בדאטה ובחירת
מדדים לפיילוט

באמצעות שימוש בדאטה, צוות
המדדים יבחר את **המדדים**
המתאימים לשימוש בפיילוט
תוך התחשבות באופי השירות,
מצב המטופלים וכן סדרי
עדיפויות לשיפור השירות
(בשקפים הבאים מופיעים קווים
מנחים לבחירת מדדים).
מסקירת תוכניות דומות בעולם
נמצא שבשלב זה נוטים
להתייעץ עם ספקי השירות
ולקבל את חוות דעתם על
המדדים אשר צפויים להיכלל
במודל.

גיבוש מתווה יישום
למדידה ובניית מודלים
לחישוב מדד

שלב זה נועד להבטיח כי
הנתונים שיגיעו מהספקים
יתקבלו בצורה עיתית
המאפשרת ניתוח ושימוש נקי
בהם. במידה וקיימים נתוני עבר
ניתן לעשות בהם שימוש לצורך
מידול הפתרון.
כמו כן, יש צורך לתכנן את
התשתית המחשובית אצל
הרגולטור והספקים ליישום
מערך המדידה.

מנגנון המודל

מדדים לאיכות טיפול

מבוססי תפוקות ותשומות



על מנת לטייב את תהליך מדידת התפוקות, אנו מציעים חלוקה של התפוקות למספר **סלי תפוקות** למדידה.

סלים אלו יאגדו תפוקות מתחום טיפולי מסויים או כאלו שנועדו לשפר היבט ספציפי במצב המטופל. בכך התמריץ ישאיר מקום לשיקול הדעת המקצועי של המטפל ויאפשר תמרוץ על תחומי טיפול.

הדוגמאות לתפוקות השונות מבוססות על דוח המלצות של וועדה ממשלתית באוסטרליה לטיוב תחום הטיפול

סלי תפוקות ותשומות למדידת הספקים

ע"פ דוח שהוגש לממשלת אוסטרליה*

ניהול הטיפול

- מערבות המטופל בתוכנית הטיפול
- תוכנית טיפול מותאמת אישית למטופל
- קשר רציף עם המשפחה
- שימוש במערכת ממוחשבת למעקב אחר הטיפול

תאום הטיפול

- הדרכה, מעקב וסיוע בנטילת תרופות
- סיוע במעקב אחר תורים וטיפולים חיצוניים
- קשר עם רופא המשפחה
- קשר עם שירותי הרווחה במקרה הצורך
- קשר עם גורמי רפואה אחרים

אורח חיים פעיל

- ביצוע פעילות גופנית קלה עם המטופל
- ביצוע פעילות גופנית עצימה
- יציאה מהבית לאזור המגורים הקרוב
- יציאה מהבית ברגל
- מפגשים חברתיים
- ביקור במרכזי יום
- ביצוע תרגילי כוח ושיווי משקל (WHO 71)

כח אדם

- אחוז מטפלות מוכשרות
- כמות עובדים מקצועיים על כל מטופל
- הכשרות נוספות ומעמיקות למטפלות
- קיום מטפלות ייעודיות למצבים טיפוליים שונים

ניהול מערכת

- זמינות מטפלות
- החלפת מטפלות מהירה במקרה של חוסר נוכחות
- שימוש במערכת ממוחשבת לניהול השירות
- מערכת שירות לקוחות
- זמן מענה על פנייה
- זמן החלפת מטפלת לאחר פנייה
- קיום מערך בקרה ומדידה פנימי לארגון
- איכות הנתונים הנאספים על-ידי החברה
- שמירה על פרטיות המטופלים

סלי תפוקות למדידת מטפלות**

אורח חיים בריא

- הדרכת המטופלים על תזונה בריאה
- הדרכות המטופלים על חשיבות הפעילות
- עידוד המטופל לביצוע פעולות יומיומיות בעצמו
- בישול ארוחה תזונתית עם המטופל
- תרגול פעולות היגיינה אישית עם המטופל או ביצוע פעולות למען המטופל במצב מחייב

* <https://agedcare.royalcommission.gov.au/publications/final-report>

** פתרון זה אינו עוסק במדידת המטפלות עצמן, אך סלים אלו הובאו כחלק ממדדי איכות מבוססי תפוקות

הרחבה: בניית תוכנית טיפול אישית



אופן תמרוץ



בניית תוכנית טיפול אישית לכל מטופל תוך אפשרות למדידת החברות והמטפלות על עמידה ביעדי התוכנית או בתוצאותיה

תדירות



עדכון תוכנית בכל מעבר בין רמות גמלה (מנדטורי) ואשרור התוכנית ע"י גורם מקצועי טיפולי אחת לתקופה שתיבחר – כל עוד לא היה שינוי מהותי במצב המטופל

קהל יעד



חברות הסיעוד/ספקי השירות, המטפלות והמטופלים

עבודה עם תוכניות טיפול אישיות משנה מהיסוד את אופן מתן השירות למטופל ואת אופי הטיפול עצמו. ההרחבה בנוגע לתוכניות הטיפול מופיע בחלק זה היות וניתן למדוד את תוכניות הטיפול והעמידה בהן בצורה של מדידת תפוקות.

- מחקרים רבים מצביאים על כך שהתאמת טיפול אישי למטופל הינה יעילה ביותר, מגדילה את ה ROI וממקסמת את תוצאות הטיפול.
- תוכנית טיפול אישית הינה תפוקה אחת מבין כלל התפוקות אשר יכולות לשפר את השירות, ומיושמת במגוון רחב של מודלים בעולם.
- על פי הרכב הגמלה שבוחר המטופל, ניתן לתכנן את כמות השעות אשר יקבל מחברות הסיעוד ולהתאים תוכנית טיפול פרטנית אשר תשאף לשמר את מצבו הבריאותי לטווח הארוך.
- מומלץ שתוכניות הטיפול יתעדכנו מעת לעת ע"פ מצב המטופל ובהתאם להרכב הגמלה אשר הוא זכאי לה (שינוי התוכנית עם שינוי זכאות הגמלה).
- תוכניות הטיפול האישיות תיבנה במשותף עם המטופל ובני משפחתו.
- אפשרות זו עשויה לעודד צריכה של שירותי טיפול במסגרת הגמלה וזאת על פני האפשרויות האחרות כדוגמת גמלה בכסף.



אפשרויות לבניית התוכנית

1

תוכניות מוגדרות מראש

וועדה מקצועית תאפיין מספר תוכניות אפשריות (חבילות) לכל רמת גמלה בהתאם למאפייני המטופלים ומצבם התפקודי כמו גם החברתי, הבריאותי ועוד

2

רשימת יעדים מוגדרת מראש

תבנה רשימת יעדים אפשרית לכלל הטיפולים. מתוכם ייבחרו היעדים אשר רלוונטיים לכל מטופל ועל גביהם יוסיף הגורם המקצועי את התפוקות הרצויות על מנת להגיע ליעדים אלו

3

תוכניות חופשיות

בניית טמפלייט לתוכנית טיפול בלבד, ללא החלטה על תוכן או הגבלה כלשהי על יעדי הטיפול או על התפוקות הרצויות מהטיפול

הרחבה: בניית תוכנית טיפול אישית

תהליך בניית תוכנית טיפול אישית



המקצועי הגורם

בעל הסמכה
במקצועות הטיפול
אשר (בעדיפות)
מתמחה בטיפול
גריאטרי, ומכיר את
גמלת הסיעוד ואת
עולם הטיפול
הסיעודי

בניית תוכנית טיפול ראשונה
גורם המקצוע נפגש עם
המטופל ובני משפחתו ויחד
מאפיינים את הצרכים של
המטופל, את החוזקות
והחולשות ומרכיבים תוכנית
טיפול בהתאם

עדכון בהתאם לפנייה של מקבל השירות או החברה
באם מקבל השירות מעוניין לשנות את תוכנית הטיפול הוא יכול להגיש בקשה.
לחלופין, אם המטפלת חשה כי התוכנית אינה מתאימה למצב המטופל ואינה משיגה
את מטרותיה ניתן להגיש בקשה לעדכון התוכנית דרך החברה

עדכון בעקבות שינוי רמת גמלה
לאחר כל החמרה ברמת הגמלה יתבצע עדכון של תוכנית הטיפול

עדכון תוכנית תקופתית
אחת למספר חודשים כפי
שיקבע יש לערוך בחינה של
התוכנית אל מול המטופל
והמטפלת ולוודא כי
התוכנית עודה עדכנית
למצבו של המטופל

מעריך הבקרה

מעריך הבקרה אחראי
בקרת איכות
התוכניות עצמן
(מדגמית), וידוא כי
לכלל המטופלים יש
תוכנית עדכנית וכי
הן מיושמות בפעול

איסוף דוחות שוטפים
איסוף דוחות מהספקים
השונים וידוא כי לכלל
המטופלים הוזנה תוכנית
אישית עדכנית

בקורות מדגמיות (תפוקתית)
בדיקה תקופתית של תוכניות טיפול רנדומליות מכלל הספקים – בדיקה זו הינה בדיקת עומק
לאיכות התוכנית וכוללת פגישה עם המטופל והמטפלת

הגורם המטפל (ספקים)

הגורם המטפל
(הספקים והמטפלות
עצמן) אחראי על
יישום תוכנית
הטיפול וכן הצפת
פערים, בעיות או
שינוי במצב המטופל

קליטת התוכנית והמטופל בחברה ותדריך המטפלת
לאחר בניית התוכנית היא
מועברת לספק אשר אחראי
על בחינתה והתאמת
המטפלת אשר תוכל למצות
ולעמוד בתוכנית הטיפול

העברת דוחות שוטפים
הספקים מחויבים להעביר
דו"חות שוטפים למעריך
הבקרה ולאפשר את
הבקורות המדגמיות

בקרה פנימית
באחריות הספק לוודא כי
הטיפול מבוצע בהתאם
לתוכנית הטיפול של כל
מטופל ומטופל

בקשה לעדכון תוכנית למטופל
אם מטפלת חשה כי
התוכנית אינה מיטבית
למטופל ניתן להגיש בקשה
לעדכון של התוכנית על ידי
הגורם המקצועי

הרחבה: בניית תוכנית טיפול אישית

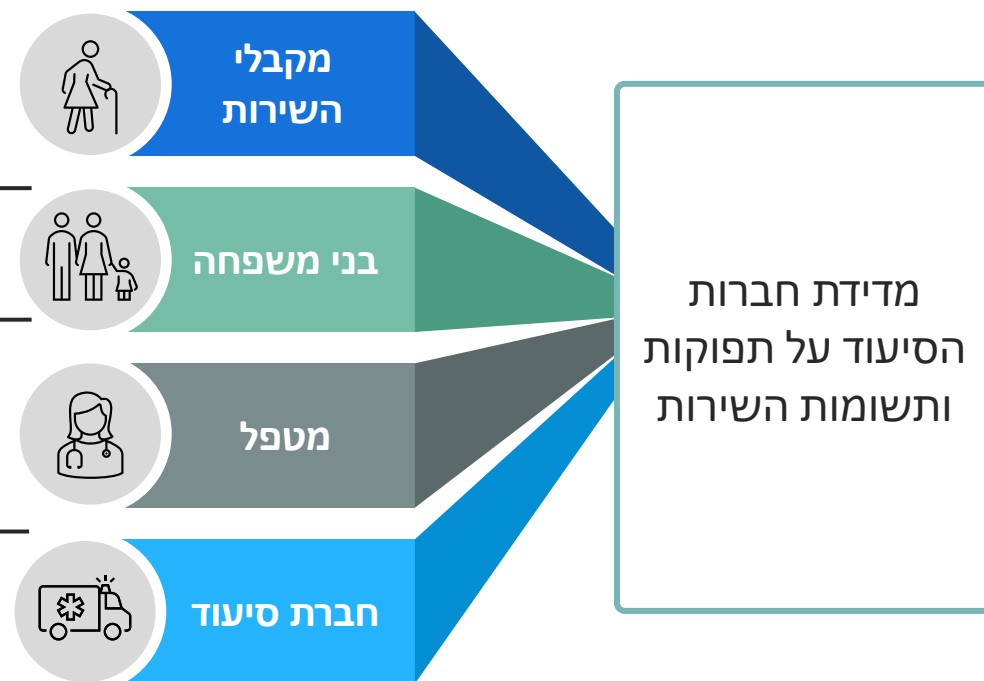


1	2	3	4
בניית התוכנית	הביטוח הלאומי	חברה חיצונית	חברות הסיעוד
כאשר הביטוח הלאומי אחראי על בניית התוכנית, מוצע לייצר מערך אשר יעסיק אנשי מקצוע (יכול להיות חלק מהערכת התלות של המטופל) אשר יהיו אחראים על בניית התוכניות ועדכוןם	חברה צד שלישי אשר תהיה אחראית על בניית התוכניות האישיות. במצב זה החברה אינה תלויה בחברות הסיעוד ואינה מחויבת להן אלא לביטוח הלאומי ולמטופל בלבד. מצב זה יכול לעודד בניית תוכניות מיטביות	גורמי המקצוע מתוך חברות הסיעוד יהיו אחראים על בניית התוכנית והצגתה למטפלות. במצב זה התהליך הטיפולי כולו באחריות חברת הסיעוד דבר אשר עשוי לזרז את תהליך בניית התוכנית אך עלול להביא איכות ירודה של התוכנית	קביעת תוכנית אישית על ידי גורם רפואי מוסמך אשר מכיר את המטופל ואת מצבו הרפואי.
בקרה על ביצוע			
הגורם אשר בנה את התוכנית יכול גם להיות אחראי על הבקרה על הספקים, הן בתחום עדכניות התוכניות והן בתחום ביצוע התוכניות עצמן	החברה עצמה יכולה להיות בקר על חברות הסיעוד בנוגע לביצוע ועמידה בתוכניות הטיפול	במקרה זה חייבת להיות בקרה הדוקה על איכות התוכניות והתאמתן למטופל, על עדכניותן ווידוא שהן קיימות לכלל המטופלים. כמו כן, יש לבצע בקרה על המטפלות ולוודא שמכירות את התוכניות של המטופלים שלהן ופועלות לפיהן.	מערך הבקרה יתמקד בכך שלכלל המטופלים יש תוכניות טיפול מעודכנות ומפורטות, ולא בהכרח בתוכן התוכנית. בנוסף, הבקרה תצטרך לוודא כי המטפלות מכירות את תוכניות הטיפול ופועלות על פיהן.

* פירוט שיטות המדידה השונות ניתן למצוא בהרחבות לפתרון
** אפשרות זו נהוגה במקרה המבחן האמריקאי המובא בהמשך

השפעות

השפעות על 4 בעלי העניין



ללא תוכנית טיפול אישית: **מדידת תשומות ותפוקות אינה בהכרח מוכוונת ליצירת שינוי בקרב מקבלי השירות.** יתכן כי מדידה אקטיבית של תפוקות ותשומות תעודד את המטופלים לדרוש את השירות המגיע להם ברמתו הגבוהה. בשילוב תוכנית טיפול אישית: **תוכניות טיפול אישיות (בוודאי כאשר יש מעורבות אקטיבית של המטופלים בבניית התוכנית) הוכחו (מקור) כיעילים בחיבור המטופל והגדלת המחויבות שלו לתהליך** ובהתאם לכך גם בשיפור תוצאות הטיפול. תוכנית טיפול מאפשר למטופל לעקוב אחר ביצועי המטפלת וחברת הסיעוד, להתאים את צרכיו לטיפול עצמו. כמו כן, בניית תוכנית טיפול אישית מכוונית את המטופל עצמו לעבר תכליות של דחיקת תלות ואף שיפור התפקוד.

במידה ובני המשפחה מעורבים בבניית תוכנית הטיפול האישית, נוצר חיבור חזק יותר לטיפול ולתכליות של דחיקת תלות. כמו כן, חיבור של המשפחה יכול לעודד את המשך הטיפול גם כאשר המטפלת אינה נמצאת והמטופל מלווה ע"י משפחתו.

פתרון זה אינו עוסק במדידת תפוקות למטפלות עצמן (אילו פעולות מבוצעות בפועל עם המטופלים) ועל כן גם בבחינת ההשפעות לא נתמקד בהכוונת המטפלות לעבר פעולות מסוימות. **על אף זאת, נראה כי בחינת החברות על התשומות ותפוקות אשר הינן מציעים למטופלים יכול לעזור בהכוונת הטיפול לעבר דחיקת תלות גם מבלי להתייחס ישירות לתפוקות המטפלות.** שיעור המטפלות המוכשרות צפוי לעלות מהרגע בו החברות ימדדו על כמות המטפלות המוכשרות. יתרה מכך, אם תתבצע מדידה של טיפולים משלימים המוענקים ע"י החברה, יתכן והחברות יבחרו להכשיר מטפלות ספציפיות למתן שירותים מיוחדים, או לאוכלוסיות מיוחדות (וכך להגדיל את התאמת הטיפול למטופל).

למדידת החברות על תשומות ותפוקות הטיפול יכולות להיות השפעות חיוביות או שליליות, וכפי שראינו לעיל **המחקרים אינם חד משמעיים בחזקת השפעת התמריצים.** מחקרים מצביעים על כך שמדידה של תפוקות מסוימות עשויות לגרום להזנחה של תפוקות ופעולות אחרות אשר נדרש לעשות עם המטופל. לפיכך, **בעת בניית מדדי התפוקות יש לבחון את ההשפעה של כל תפוקה נמדדת לנסות ולחזות את ההשפעות החריגות.** פתרון זה עשוי לשפר את הטיפול המוענק ע"י החברות וזאת ללא עלות כספית ניכרת (למעט נושא התוכניות האישיות).



אפקטיביות התמריצים לאורך הזמן ודרכים לשימורה

- עדכון המדדים אחת לשנה יכול להביא לשימור אפקטיביות התמריץ היות וכל שנה ניתן להסיר פרמטרים אשר אינם רלוונטיים יותר או שלא הצליחו ולהחליפם בפרמטרים חדשים. כך ניתן בכל פעם לתמרץ משהו אחר ולדאוג לשיפור רוחבי בענף
- פרסום של המדד באופן שוטף לציבור יכול לשמר את אפקטיביות התמריץ לאורך השנים.

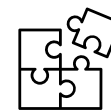


השפעות צולבות בשילוב פתרונות שונים

- **מדידת תוצאות:**
 חברות הסיעוד עשויות לטעון כי כאשר הן נמדדות על תשומות ותפוקות הטיפול ועל תוצאותיו, אין להן את הגמישות ואת היכולת לשפר את השירות על פי שיקול דעתן ובצורה שהן רואות לנכון. על כן ניתן לטעון שישנה בעייתיות לבחון אותן על כך.
- **פרסום מדדים לציבור:**
 מדידה של תפוקות מסוימות עשויה להביא להתמקדות של הספקים בשיפור תוצאותיהם והזנחה של חלקים אחרים בטיפול. פרסום של המדדים לציבור עשוי לחזק מאוד תופעה זו ולגרום לעיוותים האספקת השירותים. על מנת לפתור בעיה זו (לפחות באופן חלקי) ניתן לשלב מספר סוגי תמריצים יחדיו וכך להפחית את הסיכוי להטייה ולפגיעה בשירות.

אופן יישום

עידוד תחרות במימוש הפתרון



התאמה לחברות קטנות

יש לוודא כי בעת בחירת התפוקות ותשומות ישנה התייחסות גם לחברות קטנות או חדשות, שאין ברשותן עתודות תקציביות גדולות מדי. לדוגמה: מדידה של שירותים נוספים המוענקים ע"י החברה (מעבר לנדרש) ולא מתוגמלים בתמריץ כספי הינה בעייתית בעיקר לחברות קטנות אשר יתקשו לגייס מורות מימון והרחבת השירות



מדידה יחסית

החברות נמדדות האחת אל מול השנייה ובכך ישנו עידוד תחרות מובנה. מאיד, רוב המדדים הינם יחסיים לגודל החברה וכך נמנעת בצורה חלקית בעיה של יתרון לגודל

05. פתרונות שנבחנו אך לא נבחרו להעמקה

1. התאמה ומכוונות הטיפול

אין תמריץ מובנה במכרז לדחיקת התלות של המטופל
* ניתוח מבנה המכרז, ראיונות שטח

גמלה בכסף אינה מאפשרת מעקב אחר אופן ניצול התקציב ובקרה אחר שימוש לדחיקת תלות
* ניתוח מבנה הגמלה הנוכחי

תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

אסדרה

שינוי מבני

תמריץ שאינו כלכלי

חלוקה מבנית בין חברות סיעוד הפועלות ברמות גמלה שונות ליצירת התמחות
חלוקה של ענף הסיעוד בין רמות הגמלה הנמוכות ובין רמות הגמלה הגבוהות (5-6) כך שחברות לא יפעלו בכל הרמות אלא לכל קבוצת רמות יהיו חברות המתמחות בה.

יצירת גוף אשר אמון על מעקב וניהול כספי הגמלה
הגדרת גוף אשר אמון על ניהול כספי הגמלה של הזכאים – כל ההוצאות עוברות דרכו והוא אחראי לוודא כי יצאו לצרכים המתאימים
[אוסטרליה והולנד. מיפוי מצב קיים – סקירה בינלאומית]

הגבלת השירותים הניתנים לרכישה באמצעות כספי הגמלה
הגדרת סט של שירותים הניתנים לרכישה באמצעות כספי הגמלה אך ככל ששירות/טיפול הינו יותר מכוון לעבר דחיקת תלות כך המטופל יוכל לרכוש ממנו יותר או שמחירו יהיה נמוך ומסובסד
[מקור: אוסטרליה, מיפוי מצב קיים – סקירה בינלאומית]

יצירת תעריף לשירותי הגמלה אשר יעודד צריכת טיפולים דוחקי תלות
בניית הגמלה כאסימונים (מה שקורה היום) ללא אפשרות של המרה לכסף, כאשר התמחור של השירותים יעשה ע"פ "רמת" דחיקת התלות שהם מספקים
[מקור: מבוסס על שילוב בין הרפורמה באוסטרליה, בהולנד, וכן מבנה הגמלה הנוכחי בישראל]

1. התאמה ומכוונות הטיפול

אין הגדרה של פעולות איכות מונעות הדרדרות והמטפלות/ים אינן מוכוונות לעבר יעד זה
*הגדרת הפעולות במכרז, מחקר ברוקדייל

תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

תשלום על עמידה ביעדי תפוקות על פי תוכנית אישית או בלעדיה
הגדרת תשלום בונוס למטפלות ולחברות הסיעוד אשר יעמדו ביעדי התוכנית האישית אשר הוגדרה למטופל. התוכנית תוגדר, בין היתר, באמצעות מדדי תפוקות. המטפלות יבחנו על עמידה ביעדים האישיים של המטופלים ואילו החברות ימדדו על ממוצעים.

אסדרה

יצירת תוכנית פעולה אישית לכל מטופל
לכל מטופל תיקבע תוכנית פעולה אישית ע"י גורמי מקצוע (שאינם מטעם חברת הסיעוד). תוכנית זו תעודכן אחת לקופה או בעקבות שינוי דרסתי במצב המטופל. כמו כן תשמש התוכנית למדידת איכות השירות ותוצאותיו.
הבסיס לכל שינוי הינו הגדרה ברורה של פעולות מונעות הדרדרות.
[מקור: הולנד, אנגליה. מיפוי מצב קיים – סקירה בינלאומית]

שינוי מבני

תמריץ שאינו כלכלי

2. מיומנות הצוות המטפל והמוטיבציה שלו

אין תמריץ מובנה להכשרת מטפלות - הן מצד חברות הסיעוד והן מצד המטפלות עצמן
*ראיונות עם מטפלות וחברות הסיעוד

אין תמריץ מספק וישנו קושי רב בשימור עובדים ותיקים ואיכותיים
*מיפוי מצב קיים – ראיונות עם המטפלות וחברות הסיעוד

תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

1. תשלום דיפרנציאלי למטפלות
תשלום על שעות הכשרה + תשלום גבוה יותר למטפלות אשר עברו הכשרה, וככל שמוסיפות קורסים והכשרות נוספות השכר עולה בהתאם
2. תשלום בונוס לחברות המעניקות הכשרה מעבר לתקן
הגדרת בונוס לחברות אשר יעברו את תקן ההכשרה למטפלות (גם כאשר יקבעו תקן הכשרת חובה לכל המטפלות)

מענק התמדה:

תשלום למטפלות אשר יעבדו בענף מעל 3 שנים וזאת על מנת להגדיל את התמריץ להישארות בענף מתוך הבנה כי רוב המטפלות נוטשות את הענף בשנתיים הראשונות לתפקיד
[Provider Incentives and Healthcare Costs: Evidence from Long-Term Care Hospitals. Einav, Finkelstein and Mahoney]

אסדרה

1. הכשרת יסוד מחייבת למטפלות
הגדרת הכשרת יסוד בסיסית אותה מחוייבת לעבור כל מטפלת בתחילת תפקידה. הכשרה זו תועבר ע"י גוף חיצוני או ע"י חברות הסיעוד בהתאם להחלטת הביטוח הלאומי
[בעיות במיפוי המצב הקיים]
2. הכשרת ייעודית לפי תחומים
בניית מערך הכשרות אשר ייצר התמחות במקצוע הטיפול. לדוגמה – התמחות בטיפול בדמנציה, מצבים סיעודיים מורכבים ועוד.

תנאים סוציאליים מוגברים:

יצירת ענף עבודה מתגמל ונעים יותר באמצעות שדרוג התנאים הסוציאליים כדוגמת תשלום על מעבר בין מטופלים, תשלום על ימי חופש ועוד.
[שיחות עם מטפלות וחברות סיעוד].
עולה גם מתוך טיוטת המלצות של צוות הוועדה הבין משרדית]

שינוי מבני

הכשרות על ידי גוף חיצוני לחברות
הכשרות הבסיס למטפלות ינתנו ע"י גוף חיצוני לחברות הסיעוד אשר יתמחה בהכשרה. חברות הסיעוד יוכלו לספק הכשרות מעבר להגדרות החובה ובכך לשפר את השירות אותו הן מספקות ללקוחותיהן ואת תנאי ההעסקה של המטפלות עצמן.

תמריץ שאינו כלכלי

1. דירוג החברות על הכשרת המטפלות
מדידת החברות על רמת ההכשרה של המטפלות מעבר לתקן החובה (בין אם מעבר ל-30% המוגדר במכרז כיום ובין אם מעבר להכשרות היסוד המחייבות שהוצעו בשקף זה) ושימוש בנתון הנאסף לדירוג החברות.
[מקור: ראו 'פרסות מדדים'. נוסף: המדריך לרכש חברתי]

2. חיוב כלפי חברות הסיעוד להציג את רמת ההכשרה של כל מטפלת לפני הגעתה למטופל בפעם הראשונה

1. דירוג החברות על ותק מטפלות

מדידת החברות על ותק המטפלות אשר מועסקות בחברה ושימוש בתוצאות המדידה לצורך דירוג איכות החברה לאורך חיי ההתקשרות.

2. יצירת מערך תמיכה למטפלות

בניית מערך לתמיכה נפשית במטפלות באמצעות יצירת קבוצות תמיכה קבועות וממומנות לכלל המטפלות.
[שיחות עם מטפלות וחברות סיעוד]

3. מעורבות משפחתית

**בני משפחה
אינם תמיד
מודעים לאופן
שבו הם יכולים
לתרום לדחיקת
התלות**

* כפי שעלה מנתוני
הלמ"ס וראיונות מיפוי
המצב הקיים

**בני משפחה
אשר מוגדרים
כמטפלים
בשכר אינם
בהכרח
מוכשרים
לתפקיד**

* כפי שעלה מנתוני
הלמ"ס וראיונות מיפוי
המצב הקיים

תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

אסדרה

**מעורבות בני משפחה בתכנון וקביעת
תוכנית הטיפול האישית של המטופל**
בני המשפחה של המטופל יהיו מעורבים
בתהליך קביעת תוכנית הטיפול של
המטופל. חלק ממעורבות זו יוכלו לקבל
בני המשפחה הדרכה והנחיות כיצד יוכלו
לתרום לטיפול ולשפר את מצבו של
המטופל

**תשלום לבני משפחה מטפלים על
שעות הכשרה**
תשלום שכר עבודה על שעות הכשרה
בהם ישתתפו בני משפחה מטפלים גם
אם לא יהיו מחויבים לעבור את
ההכשרה.

**הגדרת הכשרה מחייבת לבן משפחה
מטפל ככל שאר המטפלות.**
גם בני משפחה מטפלים יהיו מחויבים
בקבלת הכשרה בסיסית זו.
יש אפשרות לשקול הדרכה מותאמת
יותר לבני משפחה אשר מועסקים רק
אצל קרוב משפחתם אשר תתמקד
במצבו הספציפי של המטופל.
[הולנד. מתוך – סקירה השוואתית של מערכות
סיעוד: גרמניה, הולנד, דנמרק וישראל,
BEHAVIORAL THINKING Q, ד"ר איל א.
אופיר וד"ר איוון קירכגסר, יוני, 2021]

שינוי מבני

תמריץ שאינו כלכלי

**פרסום וחשיפה של בני משפחה
לזכויות המטופלים וחלחול הנרטיב של
דחיקת תלות**
יצירת מערכי מידע וחשיפה של בני
המשפחה ובציבור לתחום דחיקת התלות
ולזכויות של זכאי הגמלה כך שיעודדו
קיום פעולות דוחקות תלות ויוכלו לסייע
למצב המטופל גם מחוץ לשעות הטיפול
המוגדרות

4. איכות השירות ההיקפי

אין תמריץ מובנה לחברות הסיעוד לשיפור השירות

*מסקנה מראיונות עם
חברות הסיעוד וניתוח
מבנה המכרז

אין תמריץ לחדשנות בענף ולשימוש בטכנולוגיה למניעת הדרדרות

* ראיונות עם חברות
הסיעוד וניתוח
השירותים המוצעים

תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

אסדרה

1. הקלת המעבר בין חברות הסיעוד
הקלת הבירוקרטיה של מעבר מטופל בין
חברות סיעוד.
[אוסטרליה. מיפוי מצב קיים – סקירה
בינלאומית]

2. בחירה מחודשת של חברת סיעוד
בכל תקופה
הגדרת תקופה ספציפית בה חברת
הסיעוד משרתת את המטופל ולאחר
תקופה זו על המטופל לבחור באופן
אקטיבי בחברה שברצונו.

שינוי מבני

הגדרת ברירת מחדל בבחירת החברות
הגדרת ברירת מחדל לחברות נותנות
שירותים בכל אזור בהתאם לדירוג
שנקבע לחברה. כלומר, החברות אשר
יקבלו את הניקוד הגבוה ביותר יהוו את
ברירת המחדל במערכת לטיפול בזכאים
שלא בחרו חברה באופן פעיל

תמריץ שאינו כלכלי

פרסום לציבור של אמצעים טכנולוגיים
המשומשים ע"י הספקים
פרסום לציבור של הפיתוחים והאמצעים
הטכנולוגיים אשר החברות השונות
משתמשות בהן לטיפול מיטבי בזכאים.
הפרסום יכול לעודד מבני משפחה
ומטופלים לפנות לעבר חברות מסוימות
ובעקיפין להשפיע על פיתוחים נוספים
של חברות הסיעוד

4. איכות השירות ההיקפי

**למטפלות
ולחברות אין
תמריץ לטפל
בזכאים
מורכבים וקשים
היות והשכר
הינו אחיד לכלל
המטופלים**
* ניתוח מבנה המכרז,
ראיונות שטח

תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

תשלום דיפרנציאלי לפי רמות גמלה
1. תשלום דיפרנציאלי לחברות הסיעוד
לפי רמות הגמלה של הזכאים
2. תשלום דיפרנציאלי למטפלות עצמן
לפי רמות הגמלה של המטופלים איתן הן
עובדות.

אסדרה

שינוי מבני

**חלוקה מבנית בין חברות סיעוד
הפועלות ברמות גמלה שונות ליצירת
התמחות**
חלוקה של ענף הסיעוד בין רמות הגמלה
הנמוכות ובין רמות הגמלה הגבוהות (5-
6) כך שחברות לא יפעלו בכל הרמות
אלא לכל קבוצת רמות יהיו חברות
המתמחות בה.

תמריץ שאינו כלכלי

**תמהיל מטופלים אחיד בכל חברות
הסיעוד**
הגדרה של תמהיל מטופלים אחיד בכל
חברות הסיעוד על מנת למנוע מצב של
צ'רי פיקינג ע"י חברות הסיעוד

5. מוטיבציה ומחבורות המטופל לתהליך

**עקב חוסר
במידע ובכלים
מתאימים,
מטופלים
מעדיפים
ששעות הטיפול
ינוצלו לפעולות
שאינן
מקצועיות**
* שיחה עם ביטוח
לאומי, מבנה שירותי
הגמלה, ראיונות עם
מטפלות וחברות סיעוד

תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

אסדרה

מעורבות של המטופל בהגדרת תוכנית
הטיפול האישית
המטופל יהיה חלק אינטגרלי מקביעת
היעדים לתוכנית הטיפול האישית.
מעורבות זו תייצר מחויבות גם בקרב
המטופל לתהליך הטיפול ולפעולות אשר
יעשו ע"י המטפלת עצמה.
[מקור: רפורמת הסיעוד בהולנד. מיפוי מצב
קיים – סקירה בינלאומית]

הגבלת השירותים הניתנים לרכישה
באמצעות כספי הגמלה
(מפורט באזור השפעה 1)
יצירת תעריף לשירותי הגמלה אשר
יעודד צריכת טיפולים דוחקי תלות
(מפורט באזור השפעה 1)

שינוי מבני

תמריץ שאינו כלכלי

מעורבות המטופל בתהליך
מעורבות של המטופל בתכנון הטיפול בו
מביאה למחויבות גדולה יותר, תחושת
אוטונומיה וכן ומודעות גדולה יותר
[מקור: רפורמת הסיעוד בהולנד. מיפוי מצב
קיים – סקירה בינלאומית]

6. מעטפת קהילתית (טיפול מונע, מעורבות של שירותי קהילה)

**אין חיבור בין
הטיפול בקהילה
(רפואי
וסוציאלי) לבין
הטיפול הסיעודי
הביתי**

**אין איתור
מוקדם של
זקנים בסיכון
להידרדרות
וביצוע פעולות
מניעה**

תגמול כלכלי (תשלום/קנס)

אפשרות לסבסוד נרחב יותר למרכזי יום או קהילות תומכות מרכזי יום וקהילות תומכות יכולות להביא לשיפור מצב הקשישים ומניעת הדרדרות כמו גם מניעה מהגעה למצב סיעודי מלכתחילה. כלומר, ניתן לחשוב על אפשרות של מרכזי יום וקהילות תומכות לאוכלוסיות שצפויות להגיע למצב של הזדקקות לגמלה.
[פעולות מונעות שנעשו באנגליה]

אסדרה

הגדלת היצע השירותים הקהילתיים אשר ניתן לרכוש במסגרת הגמלה הכנסת פעולות ותוכניות נוספות לגמלת הסיעוד (כדוגמת טיפולים משלימים, פיזיותרפיה וכו') וכן הגדלת הסבסוד של אפשרויות קהילתיות קיימות כדוגמת קהילה תומכת, מרכזי יום ועוד.

שינוי מבני

1. הגדלת המעורבות של הרשות המקומית בטיפול ובמניעה
הגדלת אפשרויות הפעולה והתקצוב של קהילות תומכות המנוהלות או מפקחות ע"י הרשות המקומית
[רשויות מקומיות מעורבות בתהליך גם בהולנד וגם באנגליה]

2. אירוע חיים סיעוד
בניית פלטפורמה לשיתוף מידע ותיאום בין גורמי טיפול שונים ברמת הרשות המקומית

תמריץ שאינו כלכלי

העברת האחריות למעקב אחר מטופלים לרשויות המקומיות או לקופות החולים
א. הגדרת אחריות של קופות החולים על מעקב אחר אוכלוסיות מבוגרות באמצעות ביקורים תקופתיים במרפאה או בבית הקשיש ע"י רופא.
ב. הגדרת האחריות של הרשות המקומית למעקב אחר מצב הקשישים בתחומה וסיוע בניצול ומימוש זכויותיו

מינוי קייס מנל'ר

מינוי של גורם אשר יהיה אחראי על תיק המטופל, תכנון הטיפול, בקרה על התקדמות/הדרדרות המטופל וכן עזרה במיצוי זכויותיו.
ניתן להגדיר מספר גופים אשר יספקו קייס מנל'ר: הביטוח הלאומי, הרשויות המקומיות, חברה חיצונית במרכז צל ועוד

06. צעדים להמשך

צעדים להמשך



- דיון המשך על שני פתרונות נוספים
- הקמת צוותי עבודה ממוקדים עבור כל פתרון
- לטובת בניית פיילוט על בסיס תשתית הניתוח הקיימת

מקורות למדידת תוצאות

- <https://www.medbridgeeducation.com/blog/2021/07/five-things-you-need-know-about-home-health-value-based-purchasing/>
- <https://www.cms.gov/newsroom/press-releases/cms-takes-action-improve-home-health-care-seniors-announces-intent-expand-home-health-value-based>
- <https://innovation.cms.gov/innovation-models/home-health-value-based-purchasing-model>
- Home care quality indicators based on the Resident Assessment Instrument-Home Care (RAI-HC): a systematic review
- <https://innovation.cms.gov/data-and-reports/tpr-nnahftfi-pbvhh/2022>
- <https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/09/2021-23993/medicare-and-medicaid-programs-cy-2022-home-health-prospective-payment-system-rate-update-home#h-122>
- <https://www.cms.gov/newsroom/press-releases/cms-takes-action-improve-home-health-care-seniors-announces-intent-expand-home-health-value-based>
- MELISSA O'CONNOR AND JOAN K. DAVITT, The Outcome and Assessment Information Set (OASIS): A Review of Validity and Reliability, 2012
- Aylin Wagner, René Schaffert, Nathalie Möckli, Franziska Zúñiga and Julia Dratva, *Home care quality indicators based on the Resident Assessment Instrument-Home Care (RAI-HC): a systematic review*. 2020
- Evaluation of the Home Health Value-Based Purchasing (HHVBP) Model, Fifth Annual Report, April 2022
- Development of quality indicators for in-home aged care, Evidence review summary report. December 2021
- Henriëtte G. van der Roest and Co, *Development of a novel benchmark method to identify and characterize best practices in home care across six European countries: design, baseline, and rationale of the IBenC project*. 2019
- Morris JN, Fries BE, Frijters D, Hirdes JP, Steel RK, *interRAI home care quality indicators*. BMC Geriatr 2013;13:127. doi:10.1186/1471-2318-13-127.

מקורות למדידת איכות (תפוקות)

- [Value-based providers' payment models: understanding where and under which conditions they work](#), OECD, August 2022
- https://cdn.doctorsonly.co.il/2014/10/Successes-and-Failures-of-Pay-for-Performance-in-the-UK_NEJM-2014.pdf
- Christiansen J, Leatherman S, Sutherland K. Financial incentives, healthcare providers and quality improvements: a review of the evidence. London: The Health Foundation, 2008.
- Van Herck P, De Smedt D, Annemans L, Remmen R, Rosenthal MB, Sermeus W. Systematic review: effects, design choices, and context of pay-for-performance in health care. BMC Health Serv Res 2010;10:247.
- Scott AS, P. Ait Ouakrim, D. Willenberg, L. Naccarella, L. Furler, J. Young, D. The effect of financial incentives on the quality of health care provided by primary care physicians. Cochrane Database Syst Rev 2011; Issue 9.
- <https://www.racgp.org.au/getattachment/f5841c4f-8da5-442f-a742-5fc6af002875/Pay-for-performance-programs.aspx>
- Flodgren G, Eccles MP, Shepperd S, Scott A, Parmelli E, Beyer FR. An overview of reviews evaluating the effectiveness of financial incentives in changing healthcare professional behaviours and patient outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2011:CD009255
- Quality indicators for home- and community- based aged care: A critical literature review to inform policy directions. Hui Yuan Foong¹ | Joyce Siette^{1,2} | Mikaela Jorgensen¹
- <https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2022/07/development-of-quality-indicators-for-in-home-aged-care-evidence-review-summary-report.pdf>
- World report on aging and health, world health organization, 2015
- International Profiles of Health Care Systems, The Commonwealth Fund, DECEMBER 2020